

---

# Beratungshandbuch

Gesprächsführung, Bedarfsanalyse, Einwandbehandlung

**atra.dent**

BHB 01/2026  
Fassung 01.01.2026

## **INTERN — NICHT ZUR VORLAGE BEIM KUNDEN**

Dieses Handbuch steuert die Beratung. Es wird Kundinnen und Kunden nicht vorgelegt, nicht vorgelesen und nicht zitiert. Was gegenüber dem Kunden gilt, steht ausschließlich in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und im Versicherungsschein. Wo dieses Handbuch und ein Bedingungswerk sich widersprechen, gilt das Bedingungswerk — ohne Ausnahme. Auf Nachfrage wird die Bedingungsstelle genannt, nicht dieses Handbuch.

## Inhaltsübersicht

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Zweck, Geltung und Vertraulichkeit dieses Handbuchs .....                                                     | 3  |
| 2. Grundsatz: Der Bedarf entscheidet, die Reihenfolge nur den Zweifelsfall .....                                 | 3  |
| Kapitel 1 · Gesprächsführung .....                                                                               | 5  |
| 3. Was am Telefon anders ist als im persönlichen Gespräch .....                                                  | 5  |
| 4. Die Gesprächseröffnung: Anlass, Rahmen und Einverständnis .....                                               | 6  |
| 5. Die Überleitung von der Eröffnung zur Bedarfsermittlung .....                                                 | 6  |
| 6. Zuhören, Rückspiegeln und Mitschreiben während der Bedarfsermittlung .....                                    | 7  |
| 7. Vom Bedarf zur Empfehlung: die Auswahl begründet vortragen .....                                              | 8  |
| 8. Das Angebot am Telefon darstellen: Struktur, Sprache, Dosierung von Zahlen .....                              | 9  |
| 9. Pflichtangaben, die ungefragt in jede Tarifempfehlung gehören .....                                           | 10 |
| 10. Über Erstattungshöhen sprechen, ohne eine Zusage zu geben .....                                              | 11 |
| 11. Gesprächssteuerung, wenn die Kundin oder der Kunde abschweift .....                                          | 11 |
| 12. Umgang mit Zeitdruck auf Kundenseite und auf Beraterseite .....                                              | 12 |
| 13. Bedenkzeit: annehmen, strukturieren, nicht bekämpfen .....                                                   | 13 |
| 14. Rückrufvereinbarungen verbindlich treffen und einhalten .....                                                | 13 |
| 15. Der Abschluss: die Entscheidung feststellen, nicht herbeireden .....                                         | 14 |
| 16. Ein Gespräch sauber beenden, das zu keinem Abschluss führt .....                                             | 15 |
| 17. Nachbereitung: Dokumentation, Zusagen und Übergaben .....                                                    | 16 |
| 18. Formulierungen, die in keinem atra.dent-Gespräch verwendet werden .....                                      | 16 |
| Kapitel 2 · Bedarfsanalyse .....                                                                                 | 18 |
| 19. Aufbau des Fragenkatalogs: Reihenfolge der Fragen und warum sie so liegt .....                               | 18 |
| 20. Einstiegsfragen zur Ausgangslage: Anlass, letzter Besuch, Zustand des Gebisses .....                         | 19 |
| 21. Angeratene und begonnene Behandlungen: warum dieser Ausschluss die häufigste Ent-<br>täuschung auslöst ..... | 19 |
| 22. Wie man nach angeratenen Behandlungen fragt, ohne etwas zu unterstellen .....                                | 20 |
| 23. Was aus der Antwort zu angeratenen Behandlungen folgt .....                                                  | 20 |
| 24. Fehlende Zähne: die Ausnahme, die es nur in brillant und brillant mit Selbstbehalt gibt .                    | 21 |
| 25. Bestehender Vorversicherungsschutz: was er bewirkt und wonach zu fragen ist .....                            | 22 |
| 26. Eintrittsalter: welche Tarife ab welchem Alter noch offenstehen .....                                        | 22 |
| 27. Absehbarer Implantatbedarf: Fallzahlen, Quoten und die Abgrenzung zur Krone .....                            | 23 |
| 28. Kieferorthopädie bei Erwachsenen: Limits, Wartezeiten und was daraus folgt .....                             | 24 |
| 29. Weitere bedarfsbestimmende Fragen: Parodontose, Schiene, Narkose, Prophylaxe, In-<br>lays .....              | 25 |
| 30. Budget, Selbstbehalt und Erwartung: den Rahmen erfragen, ohne ihn zu bewerten .....                          | 26 |
| 31. Von den Antworten zur Empfehlung: das Ableitungsschema in fünf Schritten .....                               | 27 |
| 32. Wenn die Empfehlungsreihenfolge nicht greift: die Fälle im Einzelnen .....                                   | 27 |
| 33. Umgang mit unklaren, unvollständigen oder ausweichenden Antworten .....                                      | 28 |
| 34. Woran man erkennt, dass kein Bedarf besteht, und was dann zu tun ist .....                                   | 29 |
| 35. Dokumentation der Bedarfsermittlung: was festgehalten wird und warum .....                                   | 29 |
| 36. Compliance-Grenzen speziell in der Bedarfsanalyse .....                                                      | 30 |
| Kapitel 3 · Einwandbehandlung .....                                                                              | 31 |
| 37. Grundhaltung: Ein Einwand ist eine Information, kein Widerstand .....                                        | 31 |
| 38. Die Grenzen: Was in der Einwandbehandlung ausdrücklich unzulässig ist .....                                  | 31 |
| 39. Einwand „Das ist mir zu viel Geld im Monat“ .....                                                            | 32 |
| 40. Einwand „Das brauche ich nicht, meine Zähne sind gesund“ .....                                               | 33 |
| 41. Einwand „Die Wartezeit ist zu lang“ .....                                                                    | 35 |
| 42. Einwand „Ich muss das erst mit meinem Partner besprechen“ .....                                              | 36 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 43. Einwand „Meine Krankenkasse zahlt doch schon“ .....                                  | 37 |
| 44. Einwand „Ich habe schlechte Erfahrungen mit Versicherungen gemacht“ .....            | 38 |
| 45. Einwand „Schicken Sie mir erst mal Unterlagen“ .....                                 | 39 |
| 46. Einwand „Ich bin zu alt dafür“ .....                                                 | 40 |
| 47. Einwand „Ich habe schon eine Zahnzusatzversicherung“ .....                           | 41 |
| 48. Einwand „Warum ist der Selbstbehalt überhaupt drin?“ .....                           | 42 |
| 49. Einwand „Was ist, wenn ich kündige — war das dann umsonst?“ .....                    | 43 |
| 50. Einwand nach der Diagnose: „Mein Zahnarzt hat mir gerade eine Krone empfohlen“ . . . | 44 |
| 51. Wenn der Einwand trägt: das Gespräch ohne Abschluss beenden .....                    | 45 |

## 1. Zweck, Geltung und Vertraulichkeit dieses Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt, wie ein Beratungsgespräch zu atra.dent geführt wird: wie es aufgebaut ist, wie der tatsächliche Bedarf ermittelt wird und wie auf Einwände geantwortet wird. Es ergänzt den Regelteil des Beratungsleitfadens um die Prosa, die sich nicht in Regeln fassen lässt. Wo der Regelteil eine Regel setzt, setzt dieses Handbuch sie in Sprache um; es widerspricht ihm nicht.

**Vertraulichkeit.** Das Handbuch ist internes Steuerungsmaterial. Es wird der Kundin oder dem Kunden nicht vorgelegt, nicht vorgelesen und nicht zitiert. Was gegenüber dem Kunden gilt, steht ausschließlich in den Bedingungswerken und im Versicherungsschein. Wo dieses Handbuch und ein Bedingungswerk sich widersprechen, gilt das Bedingungswerk — ohne Ausnahme. Bei Nachfragen zu Bedingungsinhalten wird die Bedingungsstelle genannt, nie dieses Handbuch: Interne Steuerungsunterlagen werden gegenüber Kunden weder zitiert noch erwähnt.

**Geltungsbereich.** Das Handbuch gilt für die Telefonberatung und für das persönliche Gespräch, für Erwachsene. Alle Leistungsangaben folgen dem Produktmodell atra.dent im Stand 01.01.2026: vier Tarife (atra.dent.brillant, atra.dent.brillant mit Selbstbehalt, atra.dent.balance und atra.dent.smart), Eintritt ab 18 Jahren. Beiträge sind nicht Teil des Produktmodells; die Beitragshöhe steht im konkreten Angebot und im Versicherungsschein, nicht in diesem Handbuch. Wer hier eine Beitragszahl sucht, sucht an der falschen Stelle.

**Musterformulierungen.** Die abgesetzten Kästen enthalten wörtliche Rede. Sie sind Vorlagen, keine Skripte, und zu jeder gehört der Hinweis, wann sie passt und wann nicht. Eine Formulierung am falschen Ort richtet mehr Schaden an als gar keine.

### FIKTIVES MUSTER

Alle Angaben sind erfunden. Es besteht kein Bezug zu realen Produkten, Anbietern oder Vertriebsvorgaben.

## 2. Grundsatz: Der Bedarf entscheidet, die Reihenfolge nur den Zweifelsfall

Der tragende Grundsatz der atra.dent-Beratung lautet: Maßgeblich ist der Bedarf. Die Beratung ermittelt zuerst, was gebraucht wird, und wählt danach den Tarif — nicht umgekehrt. Dieser Grundsatz trägt alle drei Kapitel dieses Handbuchs, und deshalb steht er vor ihnen.

Die Empfehlungsreihenfolge des Vertriebs — brilliant, brilliant mit Selbstbehalt, balance und smart — gilt ausschließlich bei gleichwertiger Eignung. Sie entscheidet den Zweifelsfall, nicht den Bedarfsfall. Ergibt das Gespräch, dass ein Tarif weiter hinten in der Reihenfolge besser passt,

wird dieser empfohlen. Eine solche Abweichung braucht keine Begründung gegenüber dem Vertrieb. Eine Empfehlung gegen den erkennbaren Bedarf braucht sie sehr wohl.

Der Grund für die Reihenfolge ist sachlich: Bei Zahnzusatzversicherungen ist die Nachversicherung der Regelfall, in dem etwas schiefgeht. Wer klein einsteigt und später aufstocken will, trifft auf eine erneute Gesundheitsprüfung, eine erneut beginnende Wartezeit und eine erneut beginnende Zahnstaffel. Deshalb wird bei sonst gleicher Eignung der umfassendere Tarif zuerst dargestellt.

Daraus folgt die Pflicht zur Offenheit: Passt ein günstigerer Tarif ebenso gut, wird er genannt — auch ungefragt. Die Entscheidung trifft die Kundin oder der Kunde, nicht der Berater.

Der Hintergrund ist nicht Moral, sondern Erfahrung. Ein Tarif, der nicht passt, wird storniert, sobald der erste Leistungsfall enttäuscht. Wer smart verkauft, obwohl ein Implantat absehbar ist, hat keinen Abschluss gemacht, sondern eine Beschwerde terminiert — in smart sind Implantate nicht versichert. Eine Empfehlung gegen den erkennbaren Bedarf schadet damit auch dem Vertrieb, nicht nur der Kundin oder dem Kunden.

Daraus folgt die Haltung, die dieses Handbuch trägt: Die Beratung ermittelt, was da ist; sie erzeugt es nicht. Es wird kein Bedarf geweckt und keine Sorge gestreut, die vor dem Gespräch nicht bestand. Wer ein Risiko ausmalt, das der Kunde nicht sieht, verkauft vielleicht einen Vertrag und erzeugt sicher eine Stornoquote.

Die praktische Konsequenz: Ein Gespräch, das mit einer ehrlichen Absage endet, ist ein gutes Gespräch. Es ist kein gescheitertes Gespräch, das man mit mehr Druck hätte retten können. Wer das innerlich nicht akzeptiert, hört im Gespräch weg, wenn der Bedarf nicht zur gewünschten Empfehlung passt — und genau dieses Weghören ist am Telefon hörbar.

## Kapitel 1 · Gesprächsführung

Dieses Kapitel beschreibt, wie ein Beratungsgespräch geführt wird — mit Schwerpunkt auf dem Telefonat, weil dort die meisten Gespräche stattfinden und die Fehler die teuersten sind. Es behandelt die Führung des Gesprächs, nicht seinen fachlichen Inhalt.

### ABGRENZUNG

Welche Fragen in der Bedarfsermittlung konkret gestellt werden, in welcher Reihenfolge und mit welchen Anschlussfragen, steht in Kapitel 2. Wie auf einen Einwand gegen eine bereits ausgesprochene Empfehlung geantwortet wird, steht in Kapitel 3. Der Grundsatz, der über allem steht, ist in Abschnitt 2 beschrieben.

## 3. Was am Telefon anders ist als im persönlichen Gespräch

Am Telefon fehlt der gesamte visuelle Kanal. Das hat fünf konkrete Folgen für die Gesprächsführung.

**Pausen wirken länger.** Eine Denkpause von drei Sekunden fühlt sich am Telefon wie zehn an. Der Reflex, sie zuzureden, ist der häufigste Fehler. Wer eine Frage gestellt hat, wartet. Wer nachschaut oder rechnet, sagt das an: „Ich schaue kurz nach, einen Moment.“ Stille ohne Ankündigung wird als Verbindungsabbruch gedeutet.

**Zahlen kommen nicht an.** Im persönlichen Gespräch liegt ein Blatt auf dem Tisch. Am Telefon gilt: höchstens drei Zahlen pro Gedanke, und jede Zahl bekommt eine Einheit und einen Bezug. Nicht „85, 100, 4500“, sondern „85 Prozent beim Zahnersatz — und einmal im Jahr sind 100 Euro Selbstbehalt zu tragen.“ Alles, was über drei Zahlen hinausgeht, gehört in die schriftliche Zusammenfassung.

**Verstehen muss hörbar gemacht werden.** Nicken ist unsichtbar. Deshalb wird häufiger zurückgespiegelt als im persönlichen Gespräch: „Also: eine Krone ist angeraten, ein Termin steht noch nicht.“ Das ist keine Floskel, sondern der einzige Beleg, dass beide vom Gleichen reden.

**Ablenkung ist unsichtbar.** Der Kunde kocht, fährt, hat ein Kind auf dem Arm. Wer merkt, dass die Antworten kürzer und unspezifischer werden, fragt nach.

### MUSTERFORMULIERUNG — VERMUTETE ABLENKUNG

„Ich habe den Eindruck, es ist gerade ungünstig — soll ich lieber später noch einmal anrufen?“

**Passt** wenn die Aufmerksamkeit erkennbar nachlässt.

**Passt nicht** als Vorwurf und nicht bei jemandem, der einfach knapp antwortet.

**Der Abbruch ist billiger, das Dokument fehlt.** Auflegen kostet nichts — deshalb trägt am Telefon nur, was in den ersten dreißig Sekunden an Rahmen gesetzt wird. Und es gibt kein gemeinsames Blatt: Die Bedingungsstelle muss benannt und die Unterlage nachgereicht werden. Was nicht schriftlich nachkommt, gilt als nicht gesagt.

## 4. Die Gesprächseröffnung: Anlass, Rahmen und Einverständnis

Die Eröffnung hat vier Aufgaben, und zwar in dieser Reihenfolge: sagen, wer anruft; sagen, warum; den Zeitrahmen abstimmen; das Einverständnis einholen, jetzt zu sprechen. Erst danach beginnt Beratung.

### MUSTERFORMULIERUNG – EINGEHENDER ANRUF

„atra.dent-Beratung, mein Name ist [Name]. Womit kann ich Ihnen helfen?“

Kurz, weil der Anrufende ein Anliegen hat und es loswerden will.

### MUSTERFORMULIERUNG – RÜCKRUF AUF EINE ANFRAGE

„Guten Tag, [Name] von der atra.dent-Beratung. Sie hatten über das Formular um einen Rückruf zur Zahnzusatzversicherung gebeten — passt es Ihnen gerade, oder rufe ich zu einem besseren Zeitpunkt an?“

**Passt nicht** wenn keine Anfrage vorliegt — dann darf auch keine behauptet werden.

Der Bezug auf die eigene Anfrage ist wesentlich: Er erklärt den Anruf, ohne dass ein Vorwand konstruiert wird.

Der Zeitrahmen wird aktiv gesetzt. Diese Frage kostet dreißig Sekunden und rettet Gespräche, die sonst nach acht Minuten unter Zeitdruck kollabieren.

### MUSTERFORMULIERUNG – ZEITRAHMEN

„Für einen ersten Überblick brauche ich etwa fünfzehn Minuten. Haben Sie die jetzt, oder machen wir lieber einen Termin aus?“

Zur Eröffnung gehört ein Satz zur Rolle. Diese Offenheit kostet nichts und verhindert eine falsche Erwartung, die später als Vertrauensbruch zurückkommt.

### MUSTERFORMULIERUNG – EIGENE ROLLE

„Ich berate zu den atra.dent-Tarifen, also zu unseren eigenen Produkten — einen Marktvergleich kann ich Ihnen nicht anbieten.“

Was in der Eröffnung nichts zu suchen hat: jede Andeutung von Dringlichkeit, jeder Hinweis auf angeblich auslaufende Konditionen, jede Aussage, die Beitragsvorteile an ein Datum knüpft. Künstliche Verknappung ist untersagt — sie verstößt gegen die Compliance-Grenzen und liefert der Kundin obendrein ein gutes Argument, sofort aufzulegen.

## 5. Die Überleitung von der Eröffnung zur Bedarfsermittlung

Hier entgleisen die meisten Gespräche: Der Berater springt vom Anlass direkt zum Tarif. Damit ist genau die Reihenfolge umgedreht, gegen die der Grundsatz schützt — erst der Bedarf, dann der Tarif.

Sauber ist eine angekündigte Überleitung. Sie leistet drei Dinge: Sie begründet die Fragen, sie kündigt ihren Charakter an, und sie holt Zustimmung ein.

### MUSTERFORMULIERUNG – ANGEKÜNDIGTE ÜBERLEITUNG

„Damit ich Ihnen nicht irgendetwas anbiete, sondern das Passende, würde ich Ihnen erst ein paar Fragen zu Ihrer Zahnsituation stellen. Manche davon sind etwas persönlich — Sie müssen nichts beantworten, was Sie nicht möchten. Ist das in Ordnung?“

**Passt** in nahezu jedem Gespräch.

**Passt nicht** wenn die Kundin bereits von sich aus detailliert über ihre Zahnsituation gesprochen hat — dann wirkt sie wie ein Formular.

Hat die Kundin schon von sich aus erzählt, steigt man stattdessen mit einer Rückspiegelung ein.

#### **MUSTERFORMULIERUNG — EINSTIEG ÜBER EINE RÜCKSPIEGELUNG**

„Sie hatten die Wurzelbehandlung erwähnt — da hake ich gleich noch einmal nach.“

Ein zweiter Baustein ist der Hinweis auf die Gesundheitsangaben. Damit wird die Bedarfsermittlung von der Antragsaufnahme getrennt, was Rückfragen erspart.

#### **MUSTERFORMULIERUNG — TRENNUNG VON DER ANTRAGSAUFNAHME**

„Zum Gesundheitszustand frage ich später beim Antrag noch genauer — im Moment reicht mir ein grobes Bild.“

An einer Stelle ist die Überleitung hart: Angaben zum Gesundheitszustand werden nur mit der versicherten Person selbst besprochen, nicht mit Angehörigen am Telefon. Meldet sich der Partner und will „für meine Frau“ abschließen, wird die Bedarfsermittlung nicht begonnen, sondern verlegt.

## **6. Zuhören, Rückspiegeln und Mitschreiben während der Bedarfsermittlung**

Während der Bedarfsermittlung führt der Berater das Gespräch, redet aber wenig. Faustregel: höchstens ein Drittel Redeanteil. Wer mehr redet, erfährt weniger. Drei Techniken tragen die Phase.

**Rückspiegeln in eigenen Worten.**

#### **MUSTERFORMULIERUNG — RÜCKSPIEGELUNG**

„Verstehe ich das richtig: Sie haben seit Jahren keine größere Behandlung gehabt, aber Ihre Zahnärztin hat beim letzten Termin von einer Krone gesprochen?“

**Passt** wenn eine Aussage Folgen für die Empfehlung hat.

**Passt nicht** als Dauerbegleitung jedes Halbsatzes — dann wirkt es mechanisch.

**Nachfassen bei Vagem.** „Von einer Krone gesprochen“ kann heißen: beiläufig erwähnt — oder es liegt ein Heil- und Kostenplan vor. Der Unterschied entscheidet, denn vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen sind in allen Tarifen ausgeschlossen.

#### **MUSTERFORMULIERUNG — NACHFASSEN BEI VAGEM**

„Gibt es dazu schon einen Heil- und Kostenplan oder einen Termin?“

**Notieren, was zitiert werden muss.** Was später als Begründung auftaucht, muss wörtlich genug notiert sein, um es zurückgeben zu können. „Sie hatten gesagt, mehr als etwa dreißig Euro im

Monat sollen es nicht werden“ ist stark, wenn es die tatsächliche Aussage ist, und peinlich, wenn nicht.

Zwei Dinge geschehen hier nicht. Erstens wird nicht bewertet, ob eine Behandlung medizinisch notwendig oder sinnvoll ist — das entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt. Auf „Brauche ich das Implantat überhaupt?“ lautet die Antwort:

**MUSTERFORMULIERUNG — FRAGE NACH MEDIZINISCHER NOTWENDIGKEIT**

„Das kann ich Ihnen nicht sagen, das gehört in die Praxis. Ich kann Ihnen sagen, was versichert wäre, wenn Sie sich dafür entscheiden.“

Zweitens wird noch kein Tarif genannt — auch dann nicht, wenn nach zwei Minuten klar ist, welcher es sein wird.

## 7. Vom Bedarf zur Empfehlung: die Auswahl begründet vortragen

Zwischen Bedarfsermittlung und Angebot steht ein eigener, kurzer Schritt: die Zusammenfassung des Bedarfs und die Herleitung der Empfehlung. Er dauert eine Minute und entscheidet, ob das Angebot als Antwort oder als Verkaufsversuch gehört wird.

**MUSTERFORMULIERUNG — ZUSAMMENFASSUNG VOR DER EMPFEHLUNG**

„Ich fasse zusammen: Sie sind 41, das Gebiss ist bis auf zwei Füllungen unauffällig, angeraten ist derzeit nichts, und Implantate hatten Sie als Thema genannt, weil es in der Familie öfter vorkam. Passt das so?“

Erst die Bestätigung abwarten, dann weiter: „Auf dieser Grundlage würde ich Ihnen zwei Tarife zeigen — und dazu sagen, was der jeweils nicht kann.“

Die Herleitung nennt aktiv den ausgeschlossenen Tarif und den Grund. Das ist der wirksamste Vertrauensbeweis im Gespräch.

**MUSTERFORMULIERUNG — AUSGESCHLOSSENER TARIF**

„atra.dent.smart lasse ich weg, obwohl er der günstigste wäre. Er versichert keine Implantate — bei Ihrem Thema wäre das genau die Lücke, die Sie nicht wollen.“

Wo nach Bedarf mehrere Tarife gleichwertig geeignet sind, greift die Empfehlungsreihenfolge. Der Grund darf offen genannt werden.

**MUSTERFORMULIERUNG — BEGRÜNDUNG DER REIHENFOLGE**

„Ich fange bewusst mit dem größeren an. Aufstocken ist später der schwierige Weg — da stehen eine neue Gesundheitsprüfung, eine neue Wartezeit und eine wieder von vorn beginnende Zahnstaffel.“

Die Reihenfolge greift ausdrücklich nicht, wenn ein Budgetrahmen genannt wurde, den der vorrangige Tarif überschreitet. Dann wird der Rahmen respektiert, nicht in Frage gestellt. Sie greift auch nicht bei einem Eintrittsalter über 65 — brillant und brillant mit Selbstbehalt sind dann nicht mehr abschließbar, smart und balance bis 70 — und nicht, wenn der Bedarf erkennbar auf einen Bereich begrenzt ist, den ein kleinerer Tarif abdeckt. Die vollständige Aufzählung dieser Fälle steht in Abschnitt 32.



## 8. Das Angebot am Telefon darstellen: Struktur, Sprache, Dosierung von Zahlen

Ein Tarif wird am Telefon in vier Blöcken dargestellt, immer in derselben Reihenfolge:

- a) wofür er gedacht ist,
- b) was er im Bedarfsbereich der Kundin leistet,
- c) wo seine Grenzen liegen,
- d) was er kostet.

Die Grenzen vor dem Beitrag — wer zuerst den Beitrag nennt, verhandelt danach über Geld statt über Passung.

### MUSTERFORMULIERUNG — BALANCE, LEISTUNGSBLOCK

„atra.dent.balance deckt alle Bereiche ab — Zahnersatz, Implantate, Zahnerhalt, Parodontose, Inlays, Prophylaxe, auch Kieferorthopädie und Aufbissschienen. Beim Zahnersatz sind es 85 Prozent, beim Zahnerhalt 90. Implantate ebenfalls 85 Prozent, bis zu vier Fälle in fünf Jahren. Die Wartezeit sind drei Monate.“

Dann, ohne Übergangspause, der Grenzenblock.

### MUSTERFORMULIERUNG — BALANCE, GRENZENBLOCK

„Zwei Dinge müssen Sie dazu wissen. Erstens ein Selbstbehalt von 100 Euro — der gilt einmal im Versicherungsjahr über alle Bereiche zusammen, nicht je Bereich. Zweitens die Zahnstaffel: im ersten Jahr sind insgesamt 1.000 Euro Erstattung möglich, im zweiten kumuliert 2.000, im dritten 3.000, im vierten 4.500 — ab dem fünften Jahr fällt die Begrenzung weg.“

### MUSTERFORMULIERUNG — BRILLANT

„Bei atra.dent.brillant sind es in fast allen Bereichen 100 Prozent, kein Selbstbehalt, Implantate bis zu acht Fälle in fünf Jahren, Wartezeit drei Monate. Zwei Einschränkungen gehören dazu: Die Zahnstaffel läuft über drei Jahre — 1.500 Euro im ersten Jahr, kumuliert 3.000 im zweiten, 5.000 im dritten. Und danach gilt eine Jahreshöchstgrenze von 5.000 Euro. Vollschutz heißt also nicht unbegrenzt.“

Der letzte Satz ist Pflicht, nicht Stil: Bei brilliant sind Jahreshöchstgrenze und Zahnstaffel aktiv zu nennen, weil die Erwartung „unbegrenzt“ sonst zuverlässig entsteht.

### MUSTERFORMULIERUNG — BRILLANT MIT SELBSTBEHALT

„Leistungsseitig ist der identisch mit brilliant — wirklich identisch. Der einzige Unterschied sind 250 Euro Selbstbehalt im Versicherungsjahr, dafür ist der Beitrag niedriger.“

**Passt** für jemanden, der kleine Rechnungen ohnehin selbst trägt.

**Passt nicht** bei absehbar regelmäßigen kleineren Behandlungen, weil der Selbstbehalt dann jedes Jahr greift.

Diese Variante darf nie als „kleinerer Schutz“ dargestellt werden.

### MUSTERFORMULIERUNG — SMART

„atra.dent.smart ist der Einstieg: 60 Prozent bei Zahnersatz und Inlays, 70 beim Zahnerhalt, Prophylaxe einmal im Jahr bis 80 Euro, kein Selbstbehalt, keine Jahreshöchstgrenze.“

Direkt anschließend, ohne Nachfrage, der Lückenblock.

**MUSTERFORMULIERUNG – SMART, NICHT VERSICHERTE BEREICHE**

„Wichtig ist, was smart nicht enthält – Implantate, Parodontose, Kieferorthopädie, Funktionsanalyse und Narkose sind nicht versichert. Und die Wartezeit beträgt acht Monate, deutlich länger als bei den anderen Tarifen.“

Die Beitragshöhe stammt aus dem Rechenkern und wird zum konkreten Eintrittsalter berechnet, nicht aus dem Kopf geschätzt. „Ich rechne Ihnen das für Ihr Alter genau aus und schicke es mit“ ist die richtige Antwort, wenn keine berechnete Zahl vorliegt.

## 9. Pflichtangaben, die ungefragt in jede Tarifempfehlung gehören

Diese Angaben werden aktiv genannt, nicht auf Nachfrage. Ein Berater, der sie nur nennt, wenn gefragt wird, hat sie nicht genannt.

**Wartezeit.** Die Wartezeit des empfohlenen Tarifs wird ungefragt genannt.

| Tarif                               | Allgemeine Wartezeit | Besonderheit                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | drei Monate          | entfällt bei lückenlosem Vorversicherungsschutz; Kieferorthopädie sechs Monate |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | drei Monate          | entfällt bei lückenlosem Vorversicherungsschutz; Kieferorthopädie sechs Monate |
| atra.dent.balance                   | drei Monate          | Kieferorthopädie acht Monate                                                   |
| atra.dent.smart                     | acht Monate          | keine                                                                          |

Der Entfall bei Vorversicherung ist aktiv anzusprechen, wenn eine Vorversicherung im Gespräch war. Für Kieferorthopädie gelten eigene, längere Wartezeiten; sie entfallen auch dann nicht, wenn die allgemeine Wartezeit entfällt.

**Angeratene und begonnene Behandlungen.** Wer schon einen Heil- und Kostenplan hat, muss das wissen, bevor er unterschreibt, nicht danach. Diese Ansprache ist unangenehm und trotzdem verpflichtend; sie verhindert die teuerste Form der Enttäuschung.

**MUSTERFORMULIERUNG – AUSSCHLUSS ANGERATENER BEHANDLUNGEN**

„Wenn Ihre Zahnärztin Ihnen etwas bereits angeraten hat oder eine Behandlung begonnen ist, wird dafür nicht geleistet – das gilt in allen Tarifen.“

**Fehlende Zähne.** Bei Vertragsschluss fehlende Zähne sind ausgeschlossen. Nur brillant und brillant mit Selbstbehalt sehen eine Ausnahme vor: für bis zu zwei bei Vertragsschluss fehlende Zähne, wenn die Behandlung nach Ablauf von zwölf Monaten seit Versicherungsbeginn beginnt. Diese Ausnahme wird genau so wiedergegeben und nicht großzügiger; ausführlich steht sie in Abschnitt 24.

**Selbstbehalt, wo einer besteht.** 100 EUR bei balance, 250 EUR bei brillant mit Selbstbehalt, jeweils einmal im Versicherungsjahr über alle Leistungsbereiche zusammen. Dass es nicht je Bereich gilt, ist erfahrungsgemäß der am häufigsten missverstandene Punkt und wird deshalb explizit gesagt.

**Staffel und Höchstgrenze.** Die Zahnstaffel des empfohlenen Tarifs und, bei brillant und brillant mit Selbstbehalt, die Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR. Ergänzend, wenn es zur Situation passt: Bei unfallbedingten Behandlungen entfällt die Staffel vollständig.

**Weitere allgemeine Ausschlüsse.** Rein kosmetische Leistungen wie Bleaching oder Veneers ohne medizinische Indikation sowie Behandlungen durch nicht approbierte Behandler.

## 10. Über Erstattungshöhen sprechen, ohne eine Zusage zu geben

Die häufigste Kundenfrage lautet: „Was bekomme ich denn nun raus?“ Die Grenze ist eindeutig: Es wird keine Zusage über die Höhe einer konkreten Erstattung gegeben. Quote, Zahnstaffel, Selbstbehalt, Sublimits und die Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung wirken zusammen; verbindlich rechnet allein die Leistungsabteilung.

Die brauchbare Formulierung trennt Mechanik von Betrag.

### MUSTERFORMULIERUNG – FRAGE NACH DER ERSTATTUNGSHÖHE

„Ich kann Ihnen sagen, wie gerechnet wird, aber keine Summe zusagen — dafür spielen zu viele Dinge zusammen, unter anderem was Ihre gesetzliche Kasse vorher übernimmt. Bei balance wären es 85 Prozent des Betrags, der nach der Vorleistung Ihrer Kasse übrig bleibt, davon einmal im Jahr 100 Euro Selbstbehalt ab, und im ersten Jahr deckelt die Staffel die Summe aller Erstattungen auf 1.000 Euro. Wie das bei Ihrer konkreten Rechnung ausgeht, rechnet die Leistungsabteilung, wenn der Heil- und Kostenplan vorliegt.“

**Passt** wenn nach einer konkreten Behandlung gefragt wird.

**Passt nicht** als Antwort auf eine allgemeine Verständnisfrage — dort genügt die Quote.

Unzulässig sind Formulierungen wie „da kriegen Sie ungefähr 3.000 zurück“ oder „bei so etwas zahlen wir eigentlich immer“. Auch abgeschwächte Varianten mit „ungefähr“ oder „erfahrungsgemäß“ sind Zusagen, sobald die Kundin sie als solche hört — und sie hört sie so.

Hilft eine Beispielrechnung wirklich, wird sie als Beispiel markiert und mit runden Fantasiestellen geführt: „Nur zur Mechanik: Nehmen wir 1.000 Euro Restbetrag ...“

## 11. Gesprächssteuerung, wenn die Kundin oder der Kunde abschweift

Abschweifen ist normal und nicht per se ein Problem. Bei Zahnthemen ist es oft sogar funktional: Die Geschichte über den schlechten Zahnarzt enthält häufig genau die Information, nach der man sonst mühsam fragen müsste. Deshalb gilt: erst zuhören, dann bewerten, ob es zum Thema gehört. Drei Situationen, drei Techniken.

**Der Ausflug trägt zur Sache bei.** Nicht unterbrechen, sondern am Ende einsammeln.

### MUSTERFORMULIERUNG – AUSFLUG EINSAMMELN

„Das ist ein wichtiger Punkt — dass Sie schlechte Erfahrungen mit Zuzahlungen gemacht haben, erklärt einiges. Genau da schaue ich gleich hin.“

**Der Ausflug ist thematisch fremd, aber der Kunde ist engagiert.** Anerkennen, brücken, weitergehen. Die Anerkennung muss echt sein und darf keine Standardformel werden; zweimal derselbe Satz im selben Gespräch wird bemerkt.

**MUSTERFORMULIERUNG – BRÜCKE ZURÜCK ZUM THEMA**

„Da haben Sie recht, das ist ärgerlich. Damit ich Ihre Zeit gut nutze, gehe ich noch einmal zurück zu einer Sache, die für die Auswahl wichtig ist: ...“

**Es driftet dauerhaft.** Den Rahmen offen ansprechen.

**MUSTERFORMULIERUNG – RAHMEN NEU SETZEN**

„Wir haben noch etwa zehn Minuten. Ich stelle Ihnen zuerst die drei Fragen, die ich für eine saubere Empfehlung brauche, danach ist Zeit für alles andere. Einverstanden?“

**Passt** wenn die Zeit knapp wird.

**Passt nicht** als frühes Disziplinierungsmittel – dann wirkt es abweisend und die Kundin macht dicht.

Eine geschlossene Frage holt zuverlässiger zurück als eine offene. Nach einem langen Ausflug also nicht „Wie sieht es denn sonst bei Ihnen aus?“, sondern „Liegt bei Ihnen aktuell ein Heil- und Kostenplan vor – ja oder nein?“

Führt der Ausflug in ein Beschwerdethema, wird es weitergeleitet statt nebenbei behandelt. Nur zusagen, was tatsächlich veranlasst wird.

**MUSTERFORMULIERUNG – BESCHWERDETHEMA**

„Das gehört in die Leistungsabteilung, dort kann ich nicht für Sie entscheiden. Ich notiere es und Sorge dafür, dass sich jemand meldet.“

## 12. Umgang mit Zeitdruck auf Kundenseite und auf Beraterseite

Zeitdruck kommt aus zwei Richtungen und verlangt zwei verschiedene Reaktionen.

**Zeitdruck beim Kunden.** Reicht die Zeit erkennbar nicht, wird das Gespräch nicht beschleunigt, sondern geteilt. Eine gestraffte Beratung ist in der Praxis eine, bei der die Pflichtangaben unter den Tisch fallen.

**MUSTERFORMULIERUNG – GETEILTES GESPRÄCH**

„Ich merke, Sie müssen gleich los. Ich mache das nicht im Schnelldurchlauf, dazu gehören ein paar Punkte, die Sie wirklich gehört haben sollten. Zwei Möglichkeiten: Ich schicke Ihnen jetzt die Unterlagen und wir telefonieren in Ruhe – oder ich nenne Ihnen in zwei Minuten die grobe Richtung und wir gehen den Rest beim nächsten Mal durch.“

Bleiben nur wenige Minuten und der Kunde will abschließen: Ein Abschluss ohne genannte Wartezeit, ohne genannten Selbstbehalt und ohne Hinweis auf angeratene Behandlungen findet nicht statt. Diese vier bis fünf Sätze sind nicht verhandelbar; reicht die Zeit dafür nicht, wird der Abschluss verlegt.

**Zeitdruck beim Berater.** Der eigene Zeitdruck – Warteschleife voll, Tagesziel offen, Feierabend – ist kein Grund, das Gespräch zu verkürzen, und schon gar keiner, ihn weiterzugeben. Er ist am Telefon hörbar: schnelleres Sprechen, kürzere Pausen, weniger Rückfragen. Wer merkt, dass er drängt, bremst bewusst ab. Reicht die eigene Zeit wirklich nicht, wird das gesagt statt versteckt.

**MUSTERFORMULIERUNG – EIGENE ZEIT REICHT NICHT**

„Bei mir wird es gleich knapp, und ich möchte den Teil zu den Ausschlüssen nicht kürzen. Dürfte ich Sie morgen Vormittag noch einmal anrufen?“

In beiden Richtungen verboten bleibt jede Andeutung, ein Angebot gelte nur heute, die Konditionen änderten sich demnächst, oder der Kunde solle sich „jetzt schnell“ entscheiden. Sachliche Hinweise zu Fristen gehören schriftlich in die Unterlagen, nicht als Druckmittel ins Gespräch.

### 13. Bedenkzeit: annehmen, strukturieren, nicht bekämpfen

Der Wunsch nach Bedenkzeit oder nach Rücksprache wird ohne Gegenrede akzeptiert. Das ist keine Höflichkeit, sondern Vorgabe. „Ich möchte darüber nachdenken“ ist kein Einwand, der behandelt wird, sondern eine legitime Entscheidung über den Zeitpunkt.

Die richtige erste Reaktion ist Zustimmung, nicht Nachfassen.

#### MUSTERFORMULIERUNG – ZUSTIMMUNG ZUR BEDENKZEIT

„Das ist vernünftig. Eine Zahnzusatzversicherung schließt man einmal ab und behält sie lange – da lohnt es sich, draufzuschlafen.“

Danach, und erst danach, wird die Bedenkzeit strukturiert. Drei Schritte.

**Klären, was noch fehlt.** Eine konkrete Unsicherheit, die sich in zwei Sätzen klären lässt, wird geklärt. Entpuppt sie sich als inhaltlicher Einwand – zu teuer, kein Bedarf, Misstrauen – gehört die Behandlung nach Kapitel 3, und auch dort gilt: höchstens eine sachliche Erwiderung, kein Nachsetzen.

#### MUSTERFORMULIERUNG – OFFENE PUNKTE KLÄREN

„Damit Sie das gut abwägen können: Gibt es etwas, das Sie noch nicht wissen? Ich schicke Ihnen ohnehin die Bedingungen mit.“

**Unterlagen zusagen und liefern.** Nur zusagen, was auch geschickt wird, und nichts mitschicken, was im Gespräch nicht erwähnt wurde.

#### MUSTERFORMULIERUNG – UNTERLAGEN ZUSAGEN

„Ich schicke Ihnen die Bedingungen und eine Übersicht zu den zwei Tarifen heute per Mail.“

**Einen Rückruf vereinbaren, wenn er gewünscht ist** – nicht ungefragt. Beide Antworten sind gleich richtig, und das muss im Tonfall auch so klingen.

#### MUSTERFORMULIERUNG – RÜCKRUF ANBIETEN

„Möchten Sie, dass ich mich in ein paar Tagen noch einmal melde, oder rufen Sie lieber selbst an, wenn Sie so weit sind?“

Was hier nicht geschieht: kein „Was hält Sie denn noch ab?“ als drittes Nachhaken, kein Hinweis auf steigendes Eintrittsalter als Druckmittel, keine Andeutung, die Gesundheitsfragen könnten in ein paar Wochen ungünstiger ausfallen. Der sachliche Hinweis, dass sich der Beitrag nach dem Eintrittsalter richtet, ist zulässig – einmal, ruhig und ohne Handlungsaufforderung.

### 14. Rückrufvereinbarungen verbindlich treffen und einhalten

Ein Rückruf ist eine Zusage – und die Zuverlässigkeit dabei sagt oft mehr über die Beratung aus als der Inhalt des ersten Gesprächs.

Eine belastbare Rückrufvereinbarung enthält vier Angaben: Tag, Zeitfenster, Nummer und Zweck.

**MUSTERFORMULIERUNG – RÜCKRUF VEREINBAREN**

„Dann rufe ich Sie am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr an, auf dieser Nummer – und wir gehen die Fragen durch, die sich beim Lesen ergeben haben. Passt das so?“

Ein bloßes „Ich melde mich nächste Woche“ ist keine Vereinbarung, sondern eine Absichtserklärung, und wird entsprechend selten erwartet.

Der Zweck gehört dazu, weil er den Rückruf von einem Nachfassanruf unterscheidet. „Ich frage dann nach Ihrer Entscheidung“ ist ein zulässiger Zweck, wenn die Kundin ihn so vereinbart hat – aufgedrängt wird er nicht.

Der Rückruf findet im vereinbarten Fenster statt. Wer es nicht schafft, meldet sich trotzdem und sagt es. Ein unkommentiert verpasster Rückruf, der drei Tage später nachgeholt wird, kostet mehr Vertrauen als eine ehrliche Verspätung.

**MUSTERFORMULIERUNG – VERPASSTER RÜCKRUF**

„Ich hatte Donnerstag zugesagt und es nicht geschafft – das tut mir leid. Passt es Ihnen jetzt?“

Ist niemand erreichbar, gilt: höchstens zwei Versuche im vereinbarten Fenster, dann eine kurze Nachricht mit Namen, Anlass und Erreichbarkeit – und danach kein weiterer Versuch, solange keine Reaktion kommt. Wiederholtes Anrufen ohne Reaktion ist Drängen, auch wenn kein Wort fällt.

Kommt ein Angehöriger ans Telefon, wird der Anlass nur allgemein benannt. Zum Gesundheitszustand oder zu Vertragsinhalten wird gegenüber Dritten nichts gesagt.

**MUSTERFORMULIERUNG – ANGEHÖRIGER AM TELEFON**

„Es geht um eine Rückfrage zu einem Beratungsgespräch, ich versuche es später noch einmal.“

## 15. Der Abschluss: die Entscheidung feststellen, nicht herbeireden

Der Abschluss ist kein eigener Überzeugungsschritt, sondern die Feststellung einer bereits getroffenen Entscheidung. War die Bedarfsermittlung sauber und die Darstellung ehrlich, ist die Entscheidung an dieser Stelle meistens schon gefallen – in die eine oder die andere Richtung. Die passende Frage ist offen und ergebnisneutral. Beide Optionen werden gleichwertig betont.

**MUSTERFORMULIERUNG – ABSCHLUSSFRAGE**

„Wie klingt das für Sie?“ – oder: „Möchten Sie das so beantragen, oder wollen Sie erst noch in die Unterlagen schauen?“

Unzulässig sind Techniken, die nur eine Richtung offen lassen: Die Alternativfrage zwischen zwei Ja-Varianten („Lieber zum Ersten oder zum Fünfzehnten?“) gehört nicht in dieses Gespräch, solange die Grundsatzentscheidung nicht gefallen ist. Nach einem klaren Ja ist sie eine praktische Frage und in Ordnung.

Vor der Antragsaufnahme wird ein letztes Mal zusammengefasst, was gilt.

**MUSTERFORMULIERUNG – ZUSAMMENFASSUNG VOR DEM ANTRAG**

„Bevor wir den Antrag aufnehmen, noch einmal die vier Punkte, die Sie kennen sollten: drei Monate Wartezeit, in den ersten drei Jahren begrenzt die Zahnstaffel die Erstattungen — 1.500, dann kumuliert 3.000, dann 5.000 Euro —, danach gilt eine Jahreshöchstgrenze von 5.000 Euro im Jahr, und für Behandlungen, die Ihnen schon angeraten wurden, wird nicht geleistet. Ist das alles klar, oder sollen wir zu einem Punkt noch einmal zurück?“

**Passt** vor jedem Abschluss.

**Passt nicht** in verkürzter Form „damit es schneller geht“ — sie ist der Kern der Beratungsdokumentation.

Danach folgt die Antragsaufnahme mit den Gesundheitsfragen. Sie werden vorgelesen wie sie stehen, nicht sinngemäß zusammengefasst, und nichts wird so kommentiert, dass es zu einer bestimmten Antwort einlädt. Ein „das kann man auch weglassen“ ist ein schwerer Fehler, egal wie harmlos der Sachverhalt scheint. Gesundheitsangaben werden nur mit der versicherten Person selbst aufgenommen.

## 16. Ein Gespräch sauber beenden, das zu keinem Abschluss führt

Ein Gespräch ohne Abschluss ist ein normales Ergebnis. Wenn der Bedarf nicht zu den Tarifen passt, ist eine Absage die richtige Beratung — und in diesem Fall geht sie vom Berater aus, nicht vom Kunden.

**MUSTERFORMULIERUNG – EHRLICHER ABBRUCH DURCH DEN BERATER**

„Ich sage es Ihnen offen: Für das, was Sie brauchen, habe ich nichts Passendes. Sie haben einen Heil- und Kostenplan für die Brücke — dafür wird in keinem unserer Tarife geleistet, weil die Behandlung schon angeraten ist. Ich könnte Ihnen jetzt etwas verkaufen, aber Sie wären enttäuscht, sobald die erste Rechnung kommt.“

**Passt** wenn der Hauptbedarf sicher nicht gedeckt ist.

**Passt nicht** als vorschnelles Aufgeben bei einem Bedarf, der nur teilweise nicht gedeckt ist — dann wird der gedeckte Teil dargestellt und die Lücke benannt, und die Entscheidung bleibt beim Kunden.

Bei einer Absage darf ein sachlicher Ausblick folgen, wenn er zutrifft — ohne Terminvereinbarung und ohne Nachfassliste, wenn der Kunde das nicht will.

**MUSTERFORMULIERUNG – AUSBLICK NACH EINER ABSAGE**

„Wenn die Brücke gemacht ist, sieht die Lage anders aus — für alles, was danach kommt, wäre eine Absicherung möglich. Melden Sie sich dann einfach.“

Der Abbruch durch den Kunden: „Ich habe kein Interesse.“ Die Antwort ist kurz, freundlich und ohne zweiten Anlauf.

**MUSTERFORMULIERUNG – KLARES DESINTERESSE**

„Alles klar, dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Danke für Ihre Zeit, und falls das Thema später aktuell wird, wissen Sie ja, wo Sie uns finden.“

Kein „Darf ich nur noch kurz...“, keine letzte Frage, kein zweiter Versuch nach einem klaren Nein. Einen echten Einwand, hinter dem eine Frage steckt, behandelt Kapitel 3; ein klares Desinteresse ist kein Einwand.

Zum sauberen Beenden gehört die Absprache über weiteren Kontakt: „Soll ich Sie aus dem Verteiler nehmen?“ Wird das bejaht, wird es umgesetzt, nicht nur notiert. Ein Gespräch ohne

Abschluss wird genauso dokumentiert wie eines mit — mit dem Grund. Der Grund ist der wertvollere Teil: Er verhindert, dass beim nächsten Kontakt wieder bei null angefangen wird.

## 17. Nachbereitung: Dokumentation, Zusagen und Übergaben

Die Nachbereitung beginnt unmittelbar nach dem Auflegen, nicht am Ende des Tages. Was nach zwei Stunden aus dem Gedächtnis rekonstruiert wird, ist unbrauchbar für die Beratungsdokumentation. Festgehalten wird:

**Der ermittelte Bedarf** in der Formulierung des Kunden, nicht in der eigenen Interpretation — insbesondere genannte Budgetrahmen, absehbare Behandlungen und vorliegende Heil- und Kostenpläne.

**Die Empfehlung mit Begründung** — und, wo von der Empfehlungsreihenfolge abgewichen wurde, der Grund. Abweichungen zugunsten eines kleineren Tarifs brauchen gegenüber dem Vertrieb keine Rechtfertigung, aber die Nachvollziehbarkeit gehört in die Akte.

**Die genannten Pflichtangaben:** welche Wartezeit, welcher Selbstbehalt, welche Staffel und welche Ausschlüsse genannt wurden. Das ist der Teil, der im Streitfall zählt.

**Offene Zusagen** mit Frist: versandte Unterlagen, vereinbarter Rückruf, weitergeleitete Beschwerden. Jede Zusage bekommt einen Termin, sonst ist sie keine.

**Bei Absagen der Grund.** „Kein Interesse“ ist keine Dokumentation. „Heil- und Kostenplan liegt vor, Hauptbedarf ausgeschlossen“ ist eine.

Fragen zur Höhe einer konkreten Erstattung und zur Auslegung einer Bedingung gehen an die Leistungsabteilung. Bei Nachfragen zu Bedingungsinhalten wird die Bedingungsstelle genannt, nie dieses Handbuch — interne Steuerungsunterlagen werden gegenüber Kunden weder zitiert noch erwähnt. Die schriftliche Zusammenfassung an den Kunden bleibt bei dem, was besprochen wurde: keine Erstattungszusagen, keine Beispielrechnungen, die als Zusage gelesen werden können, keine Formulierung, die im Gespräch nicht gefallen ist.

Welche Angaben die Bedarfsermittlung im Einzelnen hinterlässt, steht in Abschnitt 35.

## 18. Formulierungen, die in keinem atra.dent-Gespräch verwendet werden

Die Beispiele sind Muster, keine abschließende Liste. Im Zweifel gilt: Wenn eine Formulierung ihre Wirkung daraus bezieht, dass sie den Kunden schneller entscheiden lässt, als er es informiert könnte, wird sie nicht verwendet.

| Nicht verwendet wird | Beispiele und Begründung                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verknappung          | „Das Angebot gilt nur heute“, „bis Monatsende bekommen wir das noch durch“, „ich halte Ihnen den Platz bis morgen frei“. Unzulässig auch in abgeschwächter Form und auch dann, wenn eine echte Frist im Hintergrund steht. |
| Erstattungszusagen   | „Da bekommen Sie ungefähr X zurück“, „das ist praktisch komplett abgedeckt“, „so etwas zahlen wir eigentlich immer“. Verbindlich rechnet nur die Leistungsabteilung.                                                       |



| Nicht verwendet wird      | Beispiele und Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medizinische Aussagen     | „Das brauchen Sie sowieso“, „ein Implantat ist da die bessere Lösung“. Was medizinisch notwendig oder sinnvoll ist, entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt.                                                                                                                                                                            |
| Angstaufbau               | „Bei Ihrem Alter kommt da bald einiges.“ Ein sachlicher Hinweis auf tatsächliche Eigenanteile ist zulässig, eine Prognose über die Zahngesundheit des Kunden nicht.                                                                                                                                                                          |
| Verharmlosung von Grenzen | „Der Selbstbehalt ist vernachlässigbar“, „die Staffel merken Sie gar nicht“, „die Wartezeit ist nur Formsache“. Selbstbehalt, Zahnstaffel und Wartezeit sind genau die Punkte, an denen später gestritten wird.                                                                                                                              |
| Falsche Gleichsetzungen   | brillant mit Selbstbehalt als „die kleinere Variante“ zu bezeichnen ist sachlich falsch — die Leistungen sind identisch, es unterscheidet sich allein der Selbstbehalt von 250 EUR. Ebenso falsch ist smart als „Grundschutz für alles“: Implantate, Parodontose, Kieferorthopädie, Funktionsanalyse und Narkose sind dort nicht versichert. |
| Druck nach einem Nein     | „Darf ich nur noch eine einzige Frage stellen“, „geben Sie mir noch dreißig Sekunden“. Ein klares Nein wird beim ersten Mal akzeptiert.                                                                                                                                                                                                      |

## Kapitel 2 · Bedarfsanalyse

Dieses Kapitel beschreibt, wie der tatsächliche Bedarf ermittelt wird und wie daraus eine Tarifempfehlung entsteht: welche Fragen gestellt werden, in welcher Reihenfolge, mit welchen Anschlussfragen — und was aus den Antworten folgt.

### ABGRENZUNG

Gesprächsaufbau, Phasen und die Besonderheiten der Telefonberatung stehen in Kapitel 1. Einwände gegen eine bereits ausgesprochene Empfehlung stehen in Kapitel 3. Der Unterschied liegt in Zeitpunkt und Funktion: Die Bedarfsanalyse ermittelt die Lage, die Einwandbehandlung reagiert auf Widerspruch. Wer beides vermischt, behandelt Antworten der Bedarfsanalyse als Einwände und beginnt zu überzeugen, wo er noch zuhören sollte.

## 19. Aufbau des Fragenkatalogs: Reihenfolge der Fragen und warum sie so liegt

Der Fragenkatalog der Bedarfsanalyse folgt einer festen Ordnung, weil die späteren Fragen ohne die früheren nicht auswertbar sind.

| Frage                                     | Wozu                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Anlass und Ausgangslage                | Warum jetzt?                                                 |
| 2. Zahnärztliche Vorgeschichte            | Letzter Besuch, Befund, laufende Behandlung.                 |
| 3. Angeratene oder begonnene Behandlungen | Die Frage mit der größten Tragweite.                         |
| 4. Fehlende Zähne                         | Harte Ausschlussfrage mit genau einer Ausnahme.              |
| 5. Bestehender Vorversicherungsschutz     | Entscheidet über die Wartezeit bei brillant.                 |
| 6. Alter                                  | Entscheidet, welche Tarife offenstehen.                      |
| 7. Absehbarer Bedarf                      | Implantate, Kieferorthopädie, Parodontose, Schiene, Narkose. |
| 8. Erwartung und Rahmen                   | Selbstbehalt, Budget, Zeithorizont.                          |

Die Begründung ist wichtiger als die Reihenfolge selbst. Anlass und Vorgeschichte stehen vorn, weil sie das Gespräch öffnen, ohne sensibel zu sein — wer mit der Frage nach angeratenen Behandlungen einsteigt, wirkt wie eine Prüfstellung. Die Ausschlussfragen 3 bis 5 stehen in der Mitte, weil sie den Lösungsraum verkleinern: Ergibt sich hier ein Ausschluss, ändert das die gesamte spätere Empfehlung. Der Rahmen steht am Ende, weil eine Budgetfrage am Anfang wie eine Bonitätsprüfung klingt: Wer zuerst nach dem Preis gefragt wird, nennt eine Zahl, bevor er weiß, wofür.

Jede Frage wird nur einmal gestellt, und so, dass ein „nein“ eine vollwertige Antwort ist.

## 20. Einstiegsfragen zur Ausgangslage: Anlass, letzter Besuch, Zustand des Gebisses

Am Anfang der Bedarfsanalyse stehen drei offene Fragen ohne jede Wertung, deren Antworten alles Weitere steuern.

**Die Anlassfrage.** Ihr Zweck ist nicht Small Talk, sondern Einordnung: Ein Berufseinstieg ist ein anderer Anlass als eine gerade erhaltene Rechnung. Der günstigste Anlass überhaupt ist die Beratung, bevor eine Behandlung angeraten wurde, weil dann der Ausschluss angeratener Behandlungen noch nicht greift.

### MUSTERFORMULIERUNG – ANLASSFRAGE

„Was hat Sie dazu gebracht, sich gerade jetzt mit dem Thema zu befassen?“

**Passt** immer.

**Die Vorgeschichtsfrage.** Sie liefert den Zeitbezug — wer seit fünf Jahren nicht dort war, kann über angeratene Behandlungen nichts sagen — und schafft den Übergang zur Ausschlussfrage, ohne dass diese wie ein Verhör wirkt.

### MUSTERFORMULIERUNG – VORGESCHICHTSFRAGE

„Wann waren Sie zuletzt beim Zahnarzt, und was war das Ergebnis?“

**Die Zustandsfrage.** Sie lässt dem Kunden die Deutungshoheit.

### MUSTERFORMULIERUNG – ZUSTANDSFRAGE

„Wie würden Sie den Zustand Ihrer Zähne selbst einschätzen — eher unauffällig, oder gibt es Stellen, um die Sie sich Sorgen machen?“

**Passt nicht** wenn jemand erkennbar unangenehm berührt ist; dann wird sie ersatzlos gestrichen.

Wichtig für alle drei: Die Antworten sind Selbstauskunft, keine Diagnose. Ob eine Behandlung notwendig ist, entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt, nie die Beratung.

## 21. Angeratene und begonnene Behandlungen: warum dieser Ausschluss die häufigste Enttäuschung auslöst

Zu den Ausschlüssen aller vier Tarife gehören vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen. Es gibt keinen Tarif und keine Option, die diesen Ausschluss aufhebt.

Er ist der häufigste Grund für spätere Enttäuschung, und das strukturell: Genau die Situation, die Menschen zum Abschluss bewegt — der Zahnarzt hat etwas gesagt, es wird teuer —, ist die Situation, in der der Schutz für eben diese Maßnahme nicht greift. Wer das im Beratungsgespräch nicht hört, hört es im Leistungsfall, und dann ist der Vertrag verloren und der Ruf dazu. Deshalb ist der Ausschluss aktiv anzusprechen: Wer bereits einen Heil- und Kostenplan hat, muss vor der Unterschrift wissen, dass dafür nicht geleistet wird.

Praktisch bedeutet „angeraten“ mehr als „schriftlich geplant“: Auch eine mündliche Empfehlung, ein vermerkter Befund oder eine terminierte Maßnahme fällt darunter. „Begonnen“ heißt, dass die Behandlung eingeleitet wurde, etwa ein Zahn beschliffen oder ein Abdruck genommen. Wo die Grenze im Einzelfall liegt, entscheidet die Leistungsabteilung anhand des Bedingungswerks; der Berater sagt daher nie zu, dass etwas noch nicht als angeraten gilt.

Die Reichweite ist zugleich begrenzt, und auch das gehört gesagt: Ausgeschlossen ist die angeratene Maßnahme, nicht der ganze Vertrag. Wer eine angeratene Krone hat, ist nicht generell unversicherbar — alles, was danach neu entsteht, ist vom Ausschluss nicht berührt.

## 22. Wie man nach angeratenen Behandlungen fragt, ohne etwas zu unterstellen

Die Frage nach vor Vertragsschluss angeratenen oder begonnenen Behandlungen ist die heikelste der Bedarfsanalyse, weil sie leicht wie ein Misstrauensvotum klingt. Sie wird deshalb als Sachfrage gestellt, mit dem Grund davor und ohne Konjunktiv.

### MUSTERFORMULIERUNG — REGELFALL

„Ich muss Sie das fragen, weil es für den Schutz entscheidend ist: Hat Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt Ihnen zuletzt zu einer Behandlung geraten, oder ist bereits eine begonnen worden? Das ist keine Fangfrage — solche Behandlungen sind in allen unseren Tarifen ausgeschlossen. Ich möchte nur, dass Sie das vorher wissen und nicht erst mit der Rechnung.“

**Passt** sobald die Vorgeschichte erfragt ist.

**Passt nicht** als Einstiegsfrage, weil der Begründungssatz dann ins Leere läuft.

### MUSTERFORMULIERUNG — KOSTENVORANSCHLAG WURDE ERWÄHNT

„Dazu muss ich offen sein: Für eine Behandlung, die vor Vertragsschluss angeraten wurde, leistet keiner unserer Tarife. Ein Vertrag kann für alles Weitere trotzdem sinnvoll sein — aber diese eine Maßnahme würde nicht darunterfallen.“

**Passt** zwingend, sobald ein Kostenvoranschlag im Gespräch ist.

**Passt nicht** solange unklar ist, ob dahinter eine Behandlung oder nur eine Prophylaxeübersicht steht.

Was nicht gesagt wird: keine Andeutung, der Kunde könne mit dem Abschluss „noch schnell“ einer Diagnose zuvorkommen; keine Frage in der Form „Da ist doch sicher nichts angeraten, oder?“, weil sie die gewünschte Antwort mitliefert; keine Einschätzung, ob das Gesagte medizinisch geboten war.

## 23. Was aus der Antwort zu angeratenen Behandlungen folgt

Auf die Frage nach vor Vertragsschluss angeratenen oder begonnenen Behandlungen gibt es drei Antworttypen mit je eigenem Vorgehen.

**Nichts angeraten, letzter Besuch liegt nicht lange zurück.** Die günstigste Ausgangslage, weil der Ausschluss nicht greift; die Empfehlungsreihenfolge gilt ungeschmälert. Zur Sprache kommt die Wartezeit: drei Monate bei balance, brillant und brillant mit Selbstbehalt, acht Monate bei smart. Der Hinweis, dass eine Zahnzusatzversicherung im gesunden Zustand abgeschlossen wird und nicht im Schadensfall, ist hier sachlich richtig — als Feststellung, nicht als Drohung.

**Ja, es ist etwas angeraten.** Dann ist zu klären, was und in welchem Umfang. Die angeratene Maßnahme ist ausgeschlossen, alles Übrige nicht; die Empfehlung richtet sich danach, was daneben noch zu erwarten ist. Ein Vertrag kann sinnvoll bleiben, aber ohne die Erwartung, die ausgeschlossene Maßnahme mitzufinanzieren. Ausdrücklich gesagt wird: „Für diese eine Behandlung wird nicht geleistet.“ Nicht gesagt wird: „Da findet sich schon eine Lösung.“

**Unklar, weiß nicht, lange nicht dort gewesen.** Diese Antwort wird nicht umgedeutet, sondern als das dokumentiert, was sie ist: ungeklärt.

#### **MUSTERFORMULIERUNG – UNGEKLÄRTE LAGE FESTHALTEN**

„Dann halten wir fest: Nach Ihrem Kenntnisstand ist nichts angeraten. Sollte sich beim nächsten Termin etwas ergeben, fällt es unter den Ausschluss, wenn es vor Vertragsschluss angeraten wurde.“

**Passt** bei erkennbarer Unsicherheit.

**Passt nicht** wenn der Kunde bereits konkret von einer Empfehlung des Zahnarztes berichtet hat — dann ist die Lage klar.

In keinem Fall entscheidet der Berater, ob eine Äußerung des Zahnarztes bereits ein Anraten war; diese Bewertung trifft die Leistungsabteilung.

## **24. Fehlende Zähne: die Ausnahme, die es nur in brillant und brillant mit Selbstbehalt gibt**

Bei Vertragsschluss fehlende Zähne sind in allen vier Tarifen ausgeschlossen. Genau eine Ausnahme besteht, und sie gilt nur für brillant und brillant mit Selbstbehalt: Aufwendungen für den Ersatz von bis zu zwei bei Vertragsschluss fehlenden Zähnen sind erstattungsfähig, wenn die Behandlung nach Ablauf von zwölf Monaten seit Versicherungsbeginn begonnen wird. In smart und balance gibt es diese Ausnahme nicht.

Abzufragen sind drei Größen: ob Zähne fehlen, wie viele, und ob Ersatz geplant ist. Bereits ersetzte Zähne — durch Brücke, Prothese oder Implantat mit Krone — gelten nicht als Lücke. Weisheitszähne werden regelmäßig vergessen und sind ausdrücklich mitzufragen.

#### **MUSTERFORMULIERUNG – FRAGE NACH FEHLENDEN ZÄHNEN**

„Eine Frage, die viele überrascht: Fehlen Ihnen Zähne, die nicht ersetzt sind? Weisheitszähne mitgerechnet. Der Hintergrund ist, dass bei Vertragsschluss fehlende Zähne grundsätzlich ausgeschlossen sind — nur in brillant und brillant mit Selbstbehalt gibt es für bis zu zwei Zähne eine Ausnahme, wenn die Behandlung erst nach zwölf Monaten beginnt.“

**Passt** sobald die Vorgeschichte erfragt ist.

**Passt nicht** bei jemandem, der gerade von einer frischen Extraktion berichtet hat.

Die Auswertung:

| Befund                                     | Folge für die Empfehlung                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Lücke                                | Kein Einfluss auf die Tarifwahl.                                                                                                                                                                                                         |
| Ein oder zwei Lücken, Ersatz absehbar      | Nur brillant und brillant mit Selbstbehalt kommen in Betracht, dort erst bei Behandlungsbeginn nach zwölf Monaten. Wird trotzdem balance oder smart gewünscht, ist festzuhalten, dass der Ersatz dieser Zähne dort nicht versichert ist. |
| Ein oder zwei Lücken, Ersatz nicht geplant | Wird dokumentiert, prägt die Empfehlung aber nicht allein.                                                                                                                                                                               |
| Mehr als zwei Lücken                       | Für die überzähligen Zähne greift die Ausnahme auch in brillant nicht. Das ist vor dem Antrag zu sagen, nicht danach.                                                                                                                    |

Die Ausnahme ist kein allgemeiner Einschluss: Sie deckt bis zu zwei Zähne und verlangt den späteren Behandlungsbeginn — beides gehört in dieselbe Aussage, sonst bleibt die Hälfte hängen.

## 25. Bestehender Vorversicherungsschutz: was er bewirkt und wonach zu fragen ist

Ein lückenloser Vorversicherungsschutz wirkt bei brillant und brillant mit Selbstbehalt unmittelbar: Die Wartezeit von drei Monaten entfällt. Für smart (acht Monate) und balance (drei Monate) sieht das Produktmodell diesen Entfall nicht vor.

### MUSTERFORMULIERUNG — FRAGE NACH DER VORVERSICHERUNG

„Haben oder hatten Sie bereits eine Zahnzusatzversicherung — und läuft die noch, oder ist sie beendet?“

Der Zusatz zur Lückenlosigkeit ist entscheidend, denn eine vor zwei Jahren beendete Vorversicherung ist etwas anderes als ein nahtloser Übergang. Ist eine im Spiel, gehören Gesellschaft, Zeitraum und bezogene Leistungen ins Protokoll.

| Antwort                                      | Folge                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lückenloser Vorversicherungsschutz vorhanden | Ein sachliches Argument für brillant oder brillant mit Selbstbehalt, weil dort die Wartezeit entfällt. Kein Argument gegen einen anderen Tarif, wenn der Bedarf woanders liegt.                    |
| Früher versichert, inzwischen beendet        | Die Wartezeit gilt wie bei einem Neuabschluss. Zu fragen ist, warum der Vertrag endete — weil eine Kündigung nach einem enttäuschenden Leistungsfall die Erwartungshaltung prägt.                  |
| Noch laufender Vertrag                       | Dann geht es um einen Wechsel. Behandlungen, die im laufenden Vertrag bereits angeraten wurden, sind im neuen ausgeschlossen, und die Zahnstaffel beginnt neu. Beides gehört vor die Entscheidung. |
| Nie versichert                               | Keine Besonderheit.                                                                                                                                                                                |

Die Wartezeit des empfohlenen Tarifs wird in jedem Fall genannt, auch ungefragt.

## 26. Eintrittsalter: welche Tarife ab welchem Alter noch offenstehen

Das Eintrittsalter ist ein hartes Kriterium: Es entscheidet nicht, was empfehlenswert, sondern was überhaupt abschließbar ist. Es schlägt damit jede Empfehlungsreihenfolge.

| Tarif                               | Eintrittsalter  |
|-------------------------------------|-----------------|
| atra.dent.brillant                  | 18 bis 65 Jahre |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 18 bis 65 Jahre |
| atra.dent.balance                   | 18 bis 70 Jahre |
| atra.dent.smart                     | 18 bis 70 Jahre |

Praktisch heißt das: Ab 66 entfallen brillant und brillant mit Selbstbehalt vollständig aus der Empfehlung. In der Altersgruppe 66 bis 70 ist balance der umfassendste noch erreichbare Tarif und damit in aller Regel der erste, der dargestellt wird — nicht weil die Reihenfolge das sagt, sondern weil sie dort nicht mehr greift. Ab 71 ist keiner der vier Tarife mehr abschließbar; das wird ohne Umschweife gesagt.

Das Alter wird sachlich erhoben, meist ohnehin über das Geburtsdatum im Antrag. Ein entfallender Tarif wird dabei als Faktum genannt („brillant ist ab 66 nicht mehr abschließbar“) und nicht als Verlust inszeniert („da hätten Sie früher kommen müssen“).

Umgekehrt hat, wer früh einsteigt, Zeit, die Zahnstaffel zu durchlaufen — vier Versicherungsjahre bei smart und balance, drei bei brillant und brillant mit Selbstbehalt. Ein sachliches Argument für einen frühen Abschluss, aber keines für Druck.

## 27. Absehbarer Implantatbedarf: Fallzahlen, Quoten und die Abgrenzung zur Krone

Implantate sind der Leistungsbereich mit der größten Spreizung zwischen den Tarifen, und deshalb die Frage mit dem höchsten Trennwert.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung                                              |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | höchstens acht Behandlungen in fünf Versicherungsjahren |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | höchstens acht Behandlungen in fünf Versicherungsjahren |
| atra.dent.balance                   | 85 %  | höchstens vier Behandlungen in fünf Versicherungsjahren |
| atra.dent.smart                     | —     | nicht versichert                                        |

### MUSTERFORMULIERUNG — FRAGE NACH IMPLANTATEN

„Ist bei Ihnen jemals von einem Implantat die Rede gewesen — als Möglichkeit, als Empfehlung oder als etwas, das Sie sich selbst überlegt haben?“

**Passt** weil sie drei Abstufungen anbietet und keine bewertet.

**Passt nicht** in der Variante „Implantate braucht früher oder später fast jeder“, denn das ist Bedarfsweckung und keine Analyse.

Die Auswertung:

| Antwort                                        | Folge                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implantat absehbar oder ausdrücklich gewünscht | smart scheidet aus, weil der Hauptbedarf dort nicht versichert ist. Zwischen balance und brillant entscheidet die erwartete Fallzahl: Sind mehr als vier Implantate in fünf Jahren absehbar, reicht balance nicht. |
| Kein Implantatthema, aber Zahnersatz absehbar  | Dann ist die Implantatfrage nicht ausschlaggebend, und smart bleibt im Spiel — mit 60 % auf Zahnersatz gegenüber 85 % bei balance und 100 % bei brillant.                                                          |
| Bereits angeratenes Implantat                  | Dann greift der Ausschluss angeratener Behandlungen, unabhängig vom Tarif; die Fallzahlen sind für diese Maßnahme ohne Bedeutung.                                                                                  |

Eine Abgrenzung, die regelmäßig Verwirrung stiftet und deshalb aktiv erklärt wird: Zum Leistungsbereich Implantate zählen die künstliche Zahnwurzel, der Aufbau und der nötige Knochenaufbau; die aufgesetzte Krone zählt zum Zahnersatz. Eine Implantatversorgung verteilt sich also auf zwei Leistungsbereiche mit zwei Quoten: bei balance 85 % auf beides, bei brillant 100 % auf beides; bei smart ist der Implantatteil gar nicht versichert, während die Krone zu 60 % unter Zahnersatz fällt. Was dabei nicht fällt, ist eine Zusage über die Höhe der Erstattung – verbindlich rechnet nur die Leistungsabteilung.

## 28. Kieferorthopädie bei Erwachsenen: Limits, Wartezeiten und was daraus folgt

Kieferorthopädie bei Erwachsenen ist in den Tarifen sehr unterschiedlich geregelt und wird fast nie von sich aus angesprochen. Deshalb gehört sie fest in den Fragenkatalog.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung       | Wartezeit    |
|-------------------------------------|-------|------------------|--------------|
| atra.dent.brillant                  | 70 %  | 2.000 EUR gesamt | sechs Monate |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 70 %  | 2.000 EUR gesamt | sechs Monate |
| atra.dent.balance                   | 60 %  | 1.200 EUR gesamt | acht Monate  |
| atra.dent.smart                     | —     | nicht versichert | —            |

Die Limits sind Gesamtlimits über die Vertragsdauer, nicht Jahreslimits. Das ist der Punkt, an dem die Erwartung am häufigsten auseinandergeht, und er wird ausdrücklich gesagt.

### MUSTERFORMULIERUNG – FRAGE NACH KIEFERORTHOPÄDIE

„Ist eine Zahn- oder Kieferregulierung für Sie ein Thema — eine Schiene, eine feste Spange, eine Korrektur?“

**Passt** weil sie den Bereich benennt, ohne eine Absicht zu unterstellen.

**Passt nicht** in der Form „Sind Sie mit der Stellung Ihrer Zähne zufrieden?“ — das ist eine Bewertung des Aussehens und in einer Bedarfsanalyse fehlt am Platz.

Die Auswertung ist einfach: Ist Kieferorthopädie ein Thema, scheidet smart aus. Zwischen balance und brillant entscheidet die Größenordnung — die Differenz zwischen 1.200 EUR und 2.000 EUR Gesamtlimit ist bei einer Erwachsenenbehandlung erheblich. Ist Kieferorthopädie kein Thema, wird sie nicht zum Argument gemacht.

### DIE BESONDERE WARTEZEIT ENTFÄLLT NICHT MIT DER ALLGEMEINEN

Die allgemeine Wartezeit von drei Monaten entfällt bei brillant und brillant mit Selbstbehalt bei lückenlosem Vorversicherungsschutz. Die besondere Wartezeit für Kieferorthopädie entfällt dadurch nicht — sie bleibt bei sechs Monaten bestehen. Das Bedingungsmerk sagt das ausdrücklich. Wer hier vorschnell „dann entfällt alles“ sagt, erzeugt eine Erwartung, die im Leistungsfall enttäuscht wird.



## 29. Weitere bedarfsbestimmende Fragen: Parodontose, Schiene, Narkose, Prophylaxe, Inlays

Neben den großen Trennfragen geben diese Bereiche je nach Lage den Ausschlag und werden deshalb kurz abgefragt.

**Parodontose.** Ist der Bereich ein Thema, scheidet smart aus.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung       |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | keine            |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | keine            |
| atra.dent.balance                   | 80 %  | keine            |
| atra.dent.smart                     | —     | nicht versichert |

### MUSTERFORMULIERUNG – PARODONTOSE

„Ist bei Ihnen schon einmal von Zahnfleischproblemen oder einer Parodontosebehandlung gesprochen worden?“

**Funktionsanalyse und Aufbissschiene.** Die zweite Hälfte der Frage berührt den Ausschluss angeratener Behandlungen.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung       |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | 600 EUR p. a.    |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | 600 EUR p. a.    |
| atra.dent.balance                   | 80 %  | 300 EUR p. a.    |
| atra.dent.smart                     | —     | nicht versichert |

### MUSTERFORMULIERUNG – FUNKTIONSANALYSE UND SCHIENE

„Knirschen Sie nachts, oder ist Ihnen zu einer Schiene geraten worden?“

**Narkose und Sedierung.** Nur fragen, wenn ausgeprägte Behandlungsangst zur Sprache kommt. Die örtliche Betäubung gehört zur jeweiligen Behandlung und ist kein eigener Leistungsbereich.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung                       |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | keine                            |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | keine                            |
| atra.dent.balance                   | 80 %  | nur bei medizinischer Indikation |
| atra.dent.smart                     | —     | nicht versichert                 |

**Prophylaxe.** In allen vier Tarifen versichert, aber mit sehr unterschiedlichem Deckel. Ein ehrliches Unterscheidungsmerkmal, aber kein Hauptargument für einen Vollschutztarif.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung                                                      |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | 300 EUR p. a.; Anzahl unbegrenzt                                |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | 300 EUR p. a.; Anzahl unbegrenzt                                |
| atra.dent.balance                   | 100 % | 150 EUR p. a.; höchstens zwei Behandlungen je Versicherungsjahr |
| atra.dent.smart                     | 100 % | 80 EUR p. a.; höchstens eine Behandlung je Versicherungsjahr    |

**Inlays und Zahnerhalt.** Bei laborgefertigten Inlays leistet smart 60 %, balance 85 %, brillant und brillant mit Selbstbehalt 100 % direkt gelegte Füllungen zählen zum Zahnerhalt mit 70 %, 90 % beziehungsweise 100 %.

### 30. Budget, Selbstbehalt und Erwartung: den Rahmen erfragen, ohne ihn zu bewerten

Der Rahmen wird am Ende der Bedarfsanalyse erhoben, nachdem der Bedarf steht. Drei Punkte gehören dazu.

**Der Beitragsrahmen.** Eine genannte Zahl wird respektiert und nicht in Frage gestellt; ein Budgetrahmen, den der vorrangige Tarif überschreitet, ist einer der Fälle, in denen die Empfehlungsreihenfolge nicht greift. Wird keine Zahl genannt, wird nicht nachgebohrt.

#### MUSTERFORMULIERUNG – BEITRAGSRAHMEN

„Haben Sie eine Vorstellung, was Ihnen der Schutz im Monat wert wäre?“

**Die Haltung zum Selbstbehalt.** balance hat 100 EUR Selbstbehalt, brillant mit Selbstbehalt 250 EUR, smart und brillant keinen. Der Selbstbehalt gilt einmal im Versicherungsjahr über alle Leistungsbereiche zusammen, nicht je Bereich — der am häufigsten missverstandene Punkt, ungefragt zu erklären. Wer regelmäßige kleinere Behandlungen erwartet, für den greift er jedes Jahr aufs Neue; wer selten, dann aber größere Leistungen erwartet, fährt mit ihm gut.

#### MUSTERFORMULIERUNG – HALTUNG ZUM SELBSTBEHALT

„Wäre es für Sie in Ordnung, kleinere Beträge selbst zu tragen, wenn der Beitrag dafür niedriger ist?“

**Der Zeithorizont.** Die Frage entscheidet über die Bedeutung der Wartezeit — acht Monate bei smart, drei Monate bei balance, brillant und brillant mit Selbstbehalt, wobei sie bei den brillant-Tarifen bei lückenlosem Vorversicherungsschutz entfällt. Wer kurzfristig Schutz braucht, für den ist smart nicht die passende Wahl.

#### MUSTERFORMULIERUNG – ZEITHORIZONT

„Ab wann soll der Schutz greifen?“

Zeitdruck geht in dieser Phase ausschließlich vom Kunden aus, nie vom Berater. Der Wunsch nach Bedenkzeit wird ohne Gegenrede akzeptiert.

## 31. Von den Antworten zur Empfehlung: das Ableitungsschema in fünf Schritten

Aus den Antworten der Bedarfsanalyse entsteht die Tarifempfehlung in fester Abfolge. Wer sie umdreht, landet bei einer Empfehlung, die im ersten Leistungsfall aufliegt.

**Schritt 1 — harte Kriterien anwenden.** Eintrittsalter über 65 schließt brillant und brillant mit Selbstbehalt aus, über 70 alle vier. Unversorgte Lücken mit geplantem Ersatz lassen nur brillant und brillant mit Selbstbehalt übrig, dort nur bis zu zwei Zähne bei Behandlungsbeginn nach zwölf Monaten. Liegt der Hauptbedarf in einem Bereich, den ein Tarif nicht versichert, fällt dieser Tarif aus — bei smart sind das Implantate, Parodontosebehandlung, Kieferorthopädie, Funktionsanalyse und Aufbissschiene sowie Narkose und Sedierung.

**Schritt 2 — Ausschlüsse markieren.** Vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen sind in allen Tarifen ausgeschlossen. Sie verändern nicht die Tarifauswahl, wohl aber die Erwartung, und werden hier ausgesprochen, nicht erst am Ende.

**Schritt 3 — Bedarfsschwerpunkt bestimmen.** Gesucht wird der Tarif, der den erkennbaren Schwerpunkt am besten abdeckt — das, was die Kundin oder der Kunde selbst genannt hat, nicht das, was theoretisch eintreten könnte.

**Schritt 4 — Rahmen anlegen.** Beitragsrahmen, Haltung zum Selbstbehalt und Zeithorizont auf die verbliebenen Tarife anlegen.

**Schritt 5 — erst jetzt die Reihenfolge.** Bleiben zwei oder mehr Tarife gleichwertig geeignet, entscheidet die Empfehlungsreihenfolge: brillant, brillant mit Selbstbehalt, balance, smart. Nur dann. Ist ein günstigerer Tarif ebenso geeignet, wird er genannt.

Zu jeder Empfehlung gehören unaufgefordert Wartezeit, Zahnstaffel, etwaiger Selbstbehalt und die tarifspezifischen Hinweispflichten:

| Tarif                               | Ungefragt zu nennen                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atra.dent.smart                     | Die nicht versicherten Bereiche: Implantate, Parodontosebehandlung, Kieferorthopädie, Funktionsanalyse und Aufbissschiene sowie Narkose und Sedierung.                        |
| atra.dent.balance                   | Der Selbstbehalt von 100 EUR, der einmal jährlich über alle Leistungsbereiche zusammen gilt, nicht je Bereich.                                                                |
| atra.dent.brillant                  | Die Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR und die Zahnstaffel — Vollschutz heißt nicht unbegrenzt.                                                                                 |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | Dass der Leistungsumfang mit brillant identisch ist und sich nur der Selbstbehalt von 250 EUR unterscheidet. Diese Variante darf nie als kleinerer Schutz dargestellt werden. |

## 32. Wenn die Empfehlungsreihenfolge nicht greift: die Fälle im Einzelnen

Die Empfehlungsreihenfolge gilt ausschließlich bei gleichwertiger Eignung. In folgenden Lagen greift sie nicht.

**Alter über 65.** brillant und brillant mit Selbstbehalt sind nicht abschließbar; die Reihenfolge beginnt faktisch bei balance. Ab 71 ist keiner der Tarife mehr möglich.

**Ein Budgetrahmen wurde genannt, den der vorrangige Tarif überschreitet.** Dann wird der Rahmen respektiert und der passende Tarif empfohlen, statt den Rahmen in Frage zu stellen. Zulässig ist, den umfassenderen Tarif einmal zu nennen, damit die Entscheidung informiert fällt.

**Der Bedarf ist erkennbar eng.** Deckt ein kleinerer Tarif den gesamten erkennbaren Bedarf ab, wird er empfohlen. Ein junger Versicherter ohne Vorschäden, ohne Implantatthema, ohne Kieferorthopädie und mit Wunsch nach niedrigem Beitrag ist ein smart-Kunde, auch wenn smart zuletzt steht.

**Regelmäßige kleinere Behandlungen sind absehbar.** Dann ist brillant mit Selbstbehalt trotz seines Rangs die schlechtere Wahl, weil der Selbstbehalt von 250 EUR jedes Jahr aufs Neue greift.

**Der Selbstbehalt wird grundsätzlich abgelehnt.** Dann scheiden balance und brillant mit Selbstbehalt aus; es bleiben brilliant und smart, zwischen denen der Bedarf entscheidet.

**Mehr als vier Implantate in fünf Jahren sind absehbar.** Dann reicht balance nicht, so gut es sonst passen mag.

In all diesen Fällen braucht die Abweichung keine Begründung gegenüber dem Vertrieb — eine Empfehlung gegen den erkennbaren Bedarf braucht sie.

### 33. Umgang mit unklaren, unvollständigen oder ausweichenden Antworten

Nicht jede Frage der Bedarfsanalyse wird beantwortet, und nicht jede Antwort ist eindeutig. Der Umgang damit folgt drei Regeln.

**Erstens: Eine Frage wird einmal gestellt.** Wer ausweicht, weicht mit Absicht aus. Dieselbe Frage in anderer Verpackung erneut zu stellen, ist Bohren, und beschädigt das Gespräch mehr, als die fehlende Antwort schadet. Zulässig ist eine Präzisierung, wenn die Frage erkennbar missverstanden wurde — nicht, wenn die Antwort missfällt.

**Zweitens: Die Lücke wird benannt, nicht gefüllt.**

#### MUSTERFORMULIERUNG — LÜCKE BENENNEN

„Das ist in Ordnung, wir lassen das offen. Ich sage Ihnen nur, was daran hängt: Wenn bei Vertragsschluss bereits etwas angeraten war, ist das ausgeschlossen. Sie müssen mir das nicht sagen — Sie sollten nur wissen, dass es so ist.“

**Passt** bei erkennbarem Unbehagen.

**Passt nicht** wenn der Kunde die Frage schlicht überhört hat; dann wird sie wiederholt.

**Drittens: Die Empfehlung stützt sich auf den gesicherten Teil.** Aus einer Nichtantwort wird keine Annahme gebaut, in keine Richtung. Bleibt der Implantatbedarf unklar, wird nicht vorsorglich brillant empfohlen, weil damit sicher nichts falsch sei — das wäre eine Empfehlung ins Blaue. Ist der übrige Bedarf eng, bleibt die Empfehlung eng, und die offene Frage wird benannt.

Gesundheitsangaben werden zudem nur mit der versicherten Person selbst besprochen, nicht mit Angehörigen. Meldet sich jemand für eine dritte Person, endet die Bedarfsanalyse an dieser Stelle.

Bei widersprüchlichen Angaben — etwa „nichts angeraten“ bei vorliegendem Kostenvoranschlag — wird der Widerspruch einmal sachlich und ohne Vorwurf angesprochen. Bleibt es widersprüchlich, wird beides protokolliert und nichts geglättet.

#### MUSTERFORMULIERUNG — WIDERSPRUCH ANSPRECHEN

„Damit ich es richtig festhalte: Steht hinter dem Kostenvoranschlag eine Behandlung, zu der Ihnen geraten wurde?“

### 34. Woran man erkennt, dass kein Bedarf besteht, und was dann zu tun ist

Es gibt Gespräche, in denen die Bedarfsanalyse zu dem Ergebnis kommt, dass kein Bedarf besteht. Dieses Ergebnis ist zulässig und wird nicht wegverhandelt. Anzeichen sind unter anderem: ein bestehender, gleichwertiger Vertrag ohne erkennbare Lücke; ein Alter über 70, in dem keiner der vier Tarife mehr abschließbar ist; die klare Aussage, dass nur ein Angebot verglichen werden sollte; oder eine Lage, in der der gesamte Anlass unter den Ausschluss angeratener Behandlungen fällt und daneben kein weiterer Bedarf erkennbar ist.

Der letzte Fall ist verführerisch: Wer wegen eines Heil- und Kostenplans anruft, hat einen starken Abschlusswunsch — aber genau dafür wird nicht geleistet. Ein Vertrag kann sinnvoll sein, wenn daneben ein Bedarf steht. Steht dort nichts, wird das gesagt.

#### MUSTERFORMULIERUNG — KEIN BEDARF ERKENNBAR

„Ehrlich gesagt sehe ich für Ihre jetzige Situation keinen Vorteil. Die Behandlung, um die es geht, wäre ausgeschlossen, und darüber hinaus sehe ich im Moment nichts, was einen Vertrag rechtfertigt. Wenn sich das ändert, melden Sie sich gern.“

**Passt** wenn der Bedarf tatsächlich fehlt.

**Passt nicht** als bequemer Ausweg aus einem anstrengenden Gespräch und nicht bei jemandem, der schlicht unentschlossen ist; Unentschlossenheit ist kein fehlender Bedarf, sondern ein Thema der Einwandbehandlung.

Was hier nicht getan wird: kein Suchen nach einem Ersatzbedarf, kein Ausmalen künftiger Behandlungen, kein Hinweis darauf, dass „irgendwann jeder“ etwas braucht. Ein Nichtbedarfsgespräch wird sauber beendet und dokumentiert: Es kostet einen Abschluss und erspart eine Stornierung.

### 35. Dokumentation der Bedarfsermittlung: was festgehalten wird und warum

Die Bedarfsermittlung wird so dokumentiert, dass ein Dritter Monate später nachvollziehen kann, warum genau dieser Tarif empfohlen wurde. Das dient der Rekonstruktion im Streitfall — und der ist typischerweise der erste enttäuschende Leistungsfall. Festgehalten werden:

| Angabe                                 | Ausprägung                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum, Kanal, Gesprächspartner         | Bei Telefonberatung auch, ob die versicherte Person selbst gesprochen hat. Dazu der Anlass in ihren Worten.            |
| Angeratene oder begonnene Behandlungen | Wortnah und ungeglättet, einschließlich der Angabe „unklar“. Dazu der Vermerk, dass der Ausschluss angesprochen wurde. |
| Fehlende Zähne                         | Anzahl, ob versorgt, ob Ersatz geplant.                                                                                |

| Angabe                                    | Ausprägung                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorversicherungsschutz                    | Ob vorhanden, lückenlos, Gesellschaft, Zeitraum.                                                                                                                                |
| Alter                                     | Beziehungsweise Geburtsdatum.                                                                                                                                                   |
| Genannte Bedarfsschwerpunkte              | Implantate, Kieferorthopädie, Parodontose, Funktionsanalyse, Narkose, Prophylaxe, Zahnersatz.                                                                                   |
| Genannter Rahmen                          | Budget, Haltung zum Selbstbehalt, gewünschter Beginn.                                                                                                                           |
| Empfohlener Tarif und tragende Begründung | In ein bis zwei Sätzen; bei Abweichung von der Empfehlungsreihenfolge, welcher Fall vorlag.                                                                                     |
| Erteilte Pflichthinweise                  | Wartezeit, Zahnstaffel, Selbstbehalt, nicht versicherte Bereiche, Jahreshöchstgrenze bei den brillant-Tarifen, Ausschluss angeratener Behandlungen, Ausschluss fehlender Zähne. |
| Offen gebliebene Punkte                   | Als solche, nicht als Annahme.                                                                                                                                                  |

Zwei Regeln zur Form. Erstens: Antworten und Schlussfolgerungen werden getrennt notiert. „Kunde gibt an, es sei nichts angeraten“ ist etwas anderes als „es ist nichts angeraten“. Zweitens: keine medizinischen Bewertungen. „Sanierungsbedarf erkennbar“ ist eine Diagnose und steht dem Berater nicht zu; „Kunde berichtet von mehreren Füllungen in den letzten Jahren“ ist eine Wiedergabe und ist richtig.

Wird ein günstigerer Tarif genannt und abgelehnt, gehört auch das ins Protokoll: Dass er offenstand, muss belegbar sein.

## 36. Compliance-Grenzen speziell in der Bedarfsanalyse

Die Compliance-Grenzen des Beratungsleitfadens gelten in jeder Phase. In der Bedarfsanalyse sind diese besonders leicht zu verletzen, weil die Fragen nahe an Gesundheit und Geld liegen.

**Keine Aussage zur medizinischen Notwendigkeit.** Ob eine Behandlung notwendig oder sinnvoll ist, entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt. Zulässig ist allein die Auskunft, welcher Leistungsbereich betroffen wäre und wie der Tarif dort steht.

**Keine Zusage über die Höhe einer Erstattung.** Quote, Zahnstaffel, Selbstbehalt, Sublimit und die Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung wirken zusammen; verbindlich rechnet nur die Leistungsabteilung. Besonders die Rückfrage „Was bekomme ich denn dann für meine Krone?“ verführt zu einer Zahl.

**Ausschlüsse und Wartezeit aktiv nennen**, nicht erst auf Nachfrage — angeratene und begonnene Behandlungen, bei Vertragsschluss fehlende Zähne, Wartezeit des empfohlenen Tarifs.

**Kein Drängen** und keine künstliche Verknappung.

**Keine Gesundheitsdaten über Dritte.** Solche Angaben werden nur mit der versicherten Person selbst besprochen, nicht mit Angehörigen am Telefon.

Und über allem: Bei Widerspruch zwischen diesem Handbuch und einem Bedingungswerk gilt das Bedingungswerk; auf Nachfrage wird die Bedingungsstelle genannt, nicht das interne Material.

## Kapitel 3 · Einwandbehandlung

Dieses Kapitel behandelt die Situation, in der eine Kundin oder ein Kunde einen Einwand ausspricht — also nach der Empfehlung, nicht davor. Jeder Einwand ist nach demselben Schema dargestellt: was dahintersteckt, welche Rückfrage das klärt, wie die sachliche Antwort lautet, wie sie formuliert werden kann und wann der Einwand berechtigt ist.

### ABGRENZUNG

Der Aufbau des Gesprächs, seine Phasen und die Besonderheiten am Telefon stehen in Kapitel 1. Die Fragenkataloge zur Bedarfsermittlung stehen in Kapitel 2. Antworten aus der Bedarfsanalyse sind keine Einwände: Wer beides vermischt, beginnt zu überzeugen, wo er noch zuhören sollte.

## 37. Grundhaltung: Ein Einwand ist eine Information, kein Widerstand

Einwandbehandlung bedeutet nicht, einen Einwand wegzuverhandeln. Sie bedeutet: den Einwand verstehen, ihn sachlich beantworten — und ihm recht geben, wenn er zutrifft. Der Grundsatz aus Abschnitt 2 gilt auch hier, und gerade hier: Maßgeblich ist der Bedarf, und passt ein günstigerer Tarif ebenso gut, wird er genannt.

Genau deshalb ist ein Einwand wertvoll: Er zeigt entweder, dass eine Information gefehlt hat, oder dass die Empfehlung nicht gepasst hat, oder dass es schlicht keinen Bedarf gibt. Jeder Einwand hat damit drei mögliche Ausgänge, und alle drei sind zulässige Gesprächsergebnisse.

| Ausgang              | Vorgehen                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missverständnis      | Der Einwand beruht auf einer falschen Annahme über das Produkt. Dann wird sachlich richtiggestellt — mit den Zahlen des Tarifs, nicht mit Beteuerungen. |
| Falsche Empfehlung   | Der Einwand zeigt, dass ein anderer Tarif besser passt. Dann wird der andere Tarif empfohlen, auch wenn er der kleinere ist.                            |
| Zutreffender Einwand | Es gibt keinen Bedarf, oder der Bedarf lässt sich mit diesem Produkt nicht decken. Dann wird das gesagt und das Gespräch endet ohne Abschluss.          |

Der dritte Ausgang ist kein Scheitern. Ein Gespräch, das ehrlich ohne Abschluss endet, kostet weniger als eine Police, die im ersten Leistungsfall storniert wird.

## 38. Die Grenzen: Was in der Einwandbehandlung ausdrücklich unzulässig ist

Diese Grenzen gelten in jedem Gespräch und ausnahmslos. Sie sind gerade bei Einwänden wichtig, weil dort die Versuchung am größten ist, sie zu überschreiten.

| Grenze                                    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Drängen                              | Kein Zeitdruck, keine künstliche Verknappung, keine Andeutung, ein Angebot gelte nur heute oder nur in diesem Gespräch. Der Wunsch nach Bedenkzeit oder Rücksprache wird ohne Gegenrede akzeptiert.                                                                                           |
| Kein zweiter Anlauf gegen ein klares Nein | Ein Nein wird einmal verstanden, nicht zweimal getestet. Das Angebot wird nach einer Ablehnung nicht wiederholt und nicht umformuliert erneut vorgelegt.                                                                                                                                      |
| Keine Erstattungszusage                   | Keine Zusage über die Höhe einer konkreten Erstattung. Quote, Zahnstaffel, Selbstbehalt, Sublimit und die Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung wirken zusammen; verbindlich rechnet ausschließlich die Leistungsabteilung. Beispielrechnungen sind als Beispiele zu kennzeichnen. |
| Keine Heilversprechen                     | Keine Aussage darüber, ob eine Behandlung medizinisch notwendig oder sinnvoll ist. Das entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt.                                                                                                                                                          |
| Ausschlüsse aktiv nennen                  | Vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen und bei Vertragsschluss fehlende Zähne werden von sich aus angesprochen, nicht erst auf Nachfrage.                                                                                                                                 |
| Wartezeit ungefragt nennen                | Die Wartezeit des empfohlenen Tarifs gehört in jede Empfehlung.                                                                                                                                                                                                                               |
| Keine Gesundheitsdaten über Dritte        | Angaben zum Gesundheitszustand werden nur mit der versicherten Person selbst besprochen, nicht mit Angehörigen am Telefon.                                                                                                                                                                    |
| Bedingungen haben Vorrang                 | Bei Widerspruch zwischen internem Material und Bedingungswerk gilt das Bedingungswerk.                                                                                                                                                                                                        |

Ein Verstoß gegen diese Grenzen ist kein Kavaliersdelikt und wird auch dann nicht toleriert, wenn er zu einem Abschluss geführt hat.

### 39. Einwand „Das ist mir zu viel Geld im Monat“

#### Was dahintersteckt

Der Preiseinwand ist selten ein Einwand gegen den Preis. Meistens ist er einer von drei Dingen: Der Nutzen ist noch nicht sichtbar, weil die Bedarfsermittlung zu dünn war. Oder der Beitrag übersteigt tatsächlich das Budget. Oder — der häufigste Fall — es wurde ein Tarif angeboten, der zu groß für den Bedarf ist. Ein Preiseinwand ist deshalb zuerst ein Hinweis darauf, dass die Empfehlung nicht gepasst hat, und erst danach ein Hinweis auf das Budget.

#### Rückfrage, die das klärt

„Damit ich das richtig einordne: Ist der Beitrag insgesamt zu hoch, oder ist es der Beitrag für genau diesen Leistungsumfang?“ Diese Frage trennt Budget von Nutzen. Ergänzend, wenn ein Rahmen erkennbar ist: „Haben Sie eine Vorstellung, in welchem Rahmen sich das bewegen sollte?“

#### Sachliche Antwort

Wird ein Budgetrahmen genannt, wird er respektiert und nicht in Frage gestellt. Die Empfehlungsreihenfolge entscheidet nur den Zweifelsfall bei gleichwertiger Eignung. Ein genannter Rahmen schlägt sie. Der Weg nach unten ist im Produktmodell klar abgestuft, und jede Stufe hat einen benennbaren Preis in Leistung.



**Von brillant zu brillant mit Selbstbehalt.** Der Leistungsumfang ist identisch — dieselben Quoten, dieselbe Zahnstaffel über drei Versicherungsjahre, dieselbe Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR. Der einzige Unterschied ist ein Selbstbehalt von 250 EUR je Versicherungsjahr. Diese Variante darf nicht als „kleinerer Schutz“ dargestellt werden, denn sie ist keiner.

**Von brillant zu balance.** Der Selbstbehalt beträgt 100 EUR je Versicherungsjahr über alle Leistungsbereiche zusammen. Die Quoten sinken, und die Grenzen ändern sich:

| Leistungsbereich      | brillant                                                       | balance                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zahnersatz            | 100 %                                                          | 85 %                                                          |
| Zahnerhalt            | 100 %                                                          | 90 %                                                          |
| Parodontosebehandlung | 100 %                                                          | 80 %                                                          |
| Implantate            | 100 %, höchstens acht Behandlungen in fünf Versicherungsjahren | 85 %, höchstens vier Behandlungen in fünf Versicherungsjahren |
| Kieferorthopädie      | 70 %, 2.000 EUR gesamt                                         | 60 %, 1.200 EUR gesamt                                        |

Dafür gibt es bei balance keine Jahreshöchstgrenze, und die Wartezeit ist mit drei Monaten dieselbe.

**Von balance zu smart.** Hier endet die reine Preisdiskussion. In smart sind Implantate, Parodontosebehandlung, Kieferorthopädie, Funktionsanalyse und Aufbissschiene sowie Narkose und Sedierung nicht versichert. Die Quoten liegen bei 60 % für Zahnersatz und Inlays, 70 % für Zahnerhalt und Akutbehandlung. Die Wartezeit beträgt acht Monate statt drei Monate. Diese fünf Lücken sind ausdrücklich zu nennen — sie sind der häufigste Grund für spätere Enttäuschung.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Dann drehen wir das um. Sie haben mir gesagt, was Ihnen wichtig ist — lassen Sie uns schauen, welcher Tarif das zu Ihrem Rahmen abbildet. Wenn Sie kleinere Rechnungen ohnehin selbst zahlen würden, gibt es dieselbe Leistung wie in brillant auch mit 250 EUR Selbstbehalt im Jahr. Wenn es deutlich darunter liegen soll, ist balance der nächste Schritt, und dann muss ich Ihnen sagen, was sich dabei ändert.“

**Passt** wenn der Bedarf breit ist und nur der Beitrag klemmt.

**Passt nicht** wenn die Bedarfsanalyse ergeben hat, dass ein Bereich zwingend gebraucht wird, den der kleinere Tarif nicht abdeckt — dann ist der günstigere Tarif keine Lösung, sondern eine Fehlberatung.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn auch der kleinste passende Tarif über dem Budget liegt, ist der Einwand richtig und das Gespräch endet. Ebenso, wenn der Bedarf nur mit einem Tarif zu decken wäre, der außerhalb des Rahmens liegt: Dann wird nicht ein untauglicher Tarif verkauft, weil er billiger ist. „Dann passt das im Moment nicht, und das ist völlig in Ordnung“ ist ein zulässiger Gesprächsschluss.

## 40. Einwand „Das brauche ich nicht, meine Zähne sind gesund“

### Was dahintersteckt

Meistens eine sachlich richtige Beobachtung mit einer falschen Schlussfolgerung: Der aktuelle Zustand wird auf die Zukunft fortgeschrieben. Manchmal steckt auch nur ein Abwimmeln dahinter, etwa wenn das Gespräch ungelegen kommt.

## Rückfrage, die das klärt

„Wann waren Sie zuletzt beim Zahnarzt, und stand da etwas an?“ Und, falls das offen bleibt: „Wenn morgen eine größere Behandlung anstünde — hätten Sie dafür etwas zurückgelegt, oder wäre das ein Problem?“ Die zweite Frage verschiebt das Thema vom Gesundheitszustand zur Risikotragfähigkeit, und dort gehört es hin.

## Sachliche Antwort

Ein gesundes Gebiss ist der beste Zeitpunkt für einen Abschluss, nicht der schlechteste — und zwar aus einem Grund, der im Produktmodell steht und nicht in der Verkaufslogik: Vor Vertragsabschluss angeratene oder begonnene Behandlungen sind in allen vier Tarifen ausgeschlossen, ebenso bei Vertragsschluss fehlende Zähne. Wer noch keine Diagnose hat, hat noch alle Möglichkeiten offen. Wer eine hat, hat sie für diesen Befund nicht mehr.

Dazu kommt die Zahnstaffel: In den ersten Jahren ist die Summe der Erstattungen begrenzt. Wer früh einsteigt, hat diese Jahre hinter sich, bevor er sie braucht.

| Tarif                               | nach 1 Jahren | nach 2 Jahren | nach 3 Jahren | nach 4 Jahren |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| atra.dent.brillant                  | 1.500 EUR     | 3.000 EUR     | 5.000 EUR     | —             |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 1.500 EUR     | 3.000 EUR     | 5.000 EUR     | —             |
| atra.dent.balance                   | 1.000 EUR     | 2.000 EUR     | 3.000 EUR     | 4.500 EUR     |
| atra.dent.smart                     | 500 EUR       | 1.000 EUR     | 1.500 EUR     | 2.500 EUR     |

Die Beträge sind kumuliert und gelten für die Summe aller Erstattungen seit Versicherungsbeginn.

Was hier ausdrücklich nicht passiert: Es wird nicht mit Krankheitsbildern Angst gemacht und es wird keine Aussage darüber getroffen, was medizinisch auf jemanden zukommt. Das entscheidet die Zahnärztin oder der Zahnarzt, nicht der Vertrieb.

### MUSTERFORMULIERUNG

„Das ist ein guter Ausgangspunkt, und ehrlich gesagt der einzige, an dem so ein Vertrag überhaupt uneingeschränkt funktioniert: Was der Zahnarzt bereits angeraten hat, ist in jedem unserer Tarife ausgeschlossen. Solange nichts ansteht, entscheiden Sie frei. Die Frage ist deshalb nicht, ob Ihre Zähne heute in Ordnung sind, sondern ob Sie eine vierstellige Rechnung in ein paar Jahren aus eigener Tasche zahlen wollen oder nicht.“

**Passt** wenn tatsächlich kein Befund vorliegt.

**Passt nicht** als Antwort auf jemanden, der bereits einen Heil- und Kostenplan in der Hand hält — dort gilt Abschnitt 50.

## Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn jemand das Risiko bewusst selbst tragen will und die Mittel dafür hat, ist das eine legitime Entscheidung. Eine Zahnzusatzversicherung ist kein Muss. Wer sagt „Ich lege lieber selbst zurück“, bekommt keine Gegenrede, sondern höchstens noch den Hinweis auf den Ausschluss angeratener Behandlungen, damit die Entscheidung informiert ist — und dann endet das Gespräch.

## 41. Einwand „Die Wartezeit ist zu lang“

### Was dahintersteckt

Zwei sehr verschiedene Dinge, die auseinanderzuhalten sind. Entweder ein grundsätzliches Unbehagen („ich zahle und bekomme nichts“), oder ein konkreter Anlass, weil bereits etwas ansteht. Der zweite Fall ist der ernstere und führt fast immer zum Thema angeratene Behandlung.

### Rückfrage, die das klärt

„Gibt es einen bestimmten Termin oder eine Behandlung, auf die Sie schauen?“ Wird das bejaht, ist der Einwand kein Wartezeiteinwand mehr, sondern ein Ausschlusssthema. Verneint der Kunde, geht es um die Erklärung der Wartezeit selbst.

### Sachliche Antwort

Die Wartezeiten im Produktmodell:

| Tarif                               | Allgemein                                                            | Kieferorthopädie |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| atra.dent.brillant                  | drei Monate<br>entfällt bei<br>lückenlosem<br>Vorversicherungsschutz | sechs Monate     |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | drei Monate<br>entfällt bei<br>lückenlosem<br>Vorversicherungsschutz | sechs Monate     |
| atra.dent.balance                   | drei Monate                                                          | acht Monate      |
| atra.dent.smart                     | acht Monate                                                          | nicht versichert |

Wichtig ist die Abgrenzung zur Zahnstaffel, weil beides regelmäßig verwechselt wird: Die Wartezeit ist ein Zeitraum, in dem noch nicht geleistet wird. Die Zahnstaffel ist eine Summenbegrenzung, die ab Versicherungsbeginn kumuliert und über drei Versicherungsjahre (brillant, brilliant mit Selbstbehalt) beziehungsweise vier Versicherungsjahre (balance, smart) ansteigt. Nach der Wartezeit wird geleistet – bis zur Höhe der Staffel. Beides entfällt bei unfallbedingten Behandlungen: Wer sich in der Wartezeit einen Zahn ausschlägt, fällt nicht durch das Raster der Staffel.

Die Wartezeit ist keine Verhandlungssache. Sie steht in den Bedingungen und wird weder verkürzt noch „in Ausnahmefällen“ erlassen. Wer das andeutet, macht eine Zusage, die niemand halten kann.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Drei Monate, und bei smart acht. Verkürzen kann ich das nicht, das steht in den Bedingungen. Was ich Ihnen sagen kann: Wenn Sie bereits durchgehend zahnzusatzversichert sind, entfällt die Wartezeit bei brilliant vollständig. Und bei einem Unfall greift sie ohnehin nicht.“

**Passt** als sachliche Klarstellung.

**Passt nicht** wenn dahinter eine bereits angeratene Behandlung steht – dann hilft auch eine kurze Wartezeit nicht, weil der Ausschluss unabhängig davon greift, und das muss gesagt werden.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn Schutz kurzfristig gebraucht wird, ist das Produkt der falsche Weg — und zwar bei allen Tarifen. Bei smart ist die Wartezeit von acht Monaten sogar ein ausdrückliches Ausschlusskriterium für die Empfehlung. Wer in drei Wochen einen Termin für eine bereits geplante Behandlung hat, bekommt hier keine Lösung, sondern eine klare Auskunft.

## 42. Einwand „Ich muss das erst mit meinem Partner besprechen“

### Was dahintersteckt

In der Mehrzahl der Fälle genau das, was gesagt wird: ein gemeinsam geführter Haushalt und eine gemeinsam getroffene Entscheidung. In einem Teil der Fälle ist es eine höfliche Form der Ablehnung. Beide Fälle werden gleich behandelt, denn die Unterscheidung ändert nichts an dem, was erlaubt ist.

### Rückfrage, die das klärt

Genau eine ist zulässig, und sie dient nicht dem Abschluss, sondern der Vorbereitung: „Gibt es eine Frage, die Sie dafür noch beantwortet haben sollten?“ Wenn die Antwort „nein“ lautet, ist das Thema beendet.

### Sachliche Antwort

Der Wunsch nach Rücksprache wird ohne Gegenrede akzeptiert. Das ist keine Empfehlung, sondern eine feste Grenze. Unzulässig sind sämtliche Varianten, den Wunsch zu unterlaufen: die Frage „Was würde Ihr Partner denn sagen?“ als Türöffner, das Angebot, „das Angebot bis morgen zu reservieren“, der Hinweis, der Beitrag steige mit dem Eintrittsalter, oder der Versuch, den Partner spontan ans Telefon zu holen.

Ein zweiter Punkt ist harte Pflicht: Angaben zum Gesundheitszustand werden ausschließlich mit der versicherten Person selbst besprochen. Wenn beim Rückruf der Partner ans Telefon geht und Auskunft geben will, ist das abzulehnen — freundlich, aber ohne Spielraum. Das gilt auch dann, wenn die versicherte Person zugestimmt hat, solange sie nicht selbst am Apparat ist.

Was zulässig und sinnvoll ist: der Kundin oder dem Kunden mitzugeben, worüber genau zu entscheiden ist — Tarif, Leistungsumfang, Wartezeit und die Ausschlüsse, insbesondere der Ausschluss angeratener Behandlungen und fehlender Zähne. Und ein Rückrufangebot, das die Kundin oder der Kunde annehmen oder ablehnen kann.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Selbstverständlich, das gehört besprochen. Ich schreibe Ihnen zusammen, worum es geht — den Tarif, die Wartezeit und die Punkte, für die nicht geleistet wird, damit Sie beide dieselbe Grundlage haben. Wenn Sie möchten, melde ich mich in der nächsten Woche noch einmal; wenn Ihnen das lieber ist, melden Sie sich, wenn Sie so weit sind.“

**Passt** immer.

**Passt nicht** in einer Variante, die einen Rückruftermin voraussetzt statt anzubieten.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Immer. Es gibt keinen Fall, in dem dieser Einwand unberechtigt wäre. Er kann dazu führen, dass sich niemand mehr meldet — auch das ist ein zulässiges Ergebnis und kein Anlass für einen zweiten Anlauf.

## 43. Einwand „Meine Krankenkasse zahlt doch schon“

### Was dahintersteckt

Eine ungefähr richtige Vorstellung — die gesetzliche Krankenversicherung leistet zur zahnärztlichen Versorgung — verbunden mit einer unklaren Vorstellung davon, wie weit das reicht. Häufig auch die Erinnerung an eine Rechnung, die tatsächlich gering ausgefallen ist, etwa bei einer einfachen Füllung.

### Rückfrage, die das klärt

„Haben Sie schon einmal einen Heil- und Kostenplan für Zahnersatz in der Hand gehabt?“ Wer das bejaht, kennt den Unterschied zwischen Rechnungsbetrag und Zuschuss aus eigener Anschauung. Wer verneint, bekommt die Erklärung.

### Sachliche Antwort

Die gesetzliche Krankenversicherung leistet einen Festzuschuss zur Regelversorgung. Wie hoch dieser im Einzelfall ausfällt, steht im Heil- und Kostenplan der Zahnarztpraxis, nicht in unseren Unterlagen — hier werden keine Zuschusshöhen genannt, auch nicht „ungefähr“. Der Zusatzschutz setzt an dem an, was darüber hinausgeht.

| Leistungsbereich                            | brillant | brillant mit Selbstbehalt | balance | smart |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|-------|
| Zahnersatz                                  | 100 %    | 100 %                     | 85 %    | 60 %  |
| Implantate                                  | 100 %    | 100 %                     | 85 %    | —     |
| Inlays und Onlays                           | 100 %    | 100 %                     | 85 %    | 60 %  |
| Zahnerhalt                                  | 100 %    | 100 %                     | 90 %    | 70 %  |
| Parodontosebehandlung                       | 100 %    | 100 %                     | 80 %    | —     |
| Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung | 100 %    | 100 %                     | 100 %   | 100 % |
| Kieferorthopädie                            | 70 %     | 70 %                      | 60 %    | —     |
| Funktionsanalyse und Aufbissschiene         | 100 %    | 100 %                     | 80 %    | —     |
| Narkose und Sedierung                       | 100 %    | 100 %                     | 80 %    | —     |
| Schmerzausschaltung und Akutbehandlung      | 100 %    | 100 %                     | 90 %    | 70 %  |

Ein Strich bedeutet, dass der Leistungsbereich in diesem Tarif nicht versichert ist. Auch die Deckelung unterscheidet sich, und zwar erheblich: Professionelle Zahnreinigung ist in allen vier Tarifen zu 100 % enthalten, aber unterschiedlich weit begrenzt.

| Tarif                               | Quote | Begrenzung                                                      |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | 100 % | 300 EUR p. a.; Anzahl unbegrenzt                                |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 100 % | 300 EUR p. a.; Anzahl unbegrenzt                                |
| atra.dent.balance                   | 100 % | 150 EUR p. a.; höchstens zwei Behandlungen je Versicherungsjahr |
| atra.dent.smart                     | 100 % | 80 EUR p. a.; höchstens eine Behandlung je Versicherungsjahr    |

Hier gilt eine Grenze besonders streng: Es wird keine Zusage über die Höhe einer konkreten Erstattung gemacht. Quote, Staffel, Selbstbehalt, Sublimit und die Vorleistung der Krankenkasse wirken zusammen; verbindlich rechnet die Leistungsabteilung. Wer im Gespräch eine Zahl nennt, wird beim ersten Leistungsfall daran gemessen.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Ihre Kasse zahlt einen Festzuschuss, das ist richtig. Wie hoch der ist, sehen Sie erst am Heil- und Kostenplan, und der Unterschied zum Rechnungsbetrag ist genau der Teil, um den es hier geht. Ich kann Ihnen keine konkrete Erstattung zusagen — das rechnet unsere Leistungsabteilung. Was ich Ihnen sagen kann, sind die Quoten und wofür der Tarif überhaupt leistet.“

**Passt** um die Rollenverteilung zu klären.

**Passt nicht** mit einer angehängten Beispielrechnung, die als Zusage missverstanden werden kann.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn jemand ausschließlich Regelversorgung in Anspruch nehmen will und damit zufrieden ist, ist der Zusatznutzen begrenzt und der Einwand trägt. Das ist eine Wertentscheidung, keine Wissenslücke — und sie wird respektiert.

## 44. Einwand „Ich habe schlechte Erfahrungen mit Versicherungen gemacht“

### Was dahintersteckt

Fast immer eine konkrete Geschichte: eine abgelehnte Leistung, eine Klausel, die niemand erklärt hat, ein Vertrag, der nicht das war, was verkauft wurde. Der Einwand richtet sich nicht gegen das Produkt, sondern gegen die Erwartung, wieder getäuscht zu werden.

### Rückfrage, die das klärt

„Was ist damals passiert?“ Und dann zuhören, ohne zu unterbrechen. Der Einwand ist der einzige in diesem Kapitel, bei dem die Rückfrage wichtiger ist als jede Antwort.

### Sachliche Antwort

Die Erfahrung wird nicht relativiert und der frühere Anbieter wird nicht schlechtgeredet. Was hilft, ist das Gegenteil dessen, was den Ärger ausgelöst hat: die Einschränkungen von sich aus nennen, bevor danach gefragt wird. Konkret sind das die Ausschlüsse, die in allen Tarifen gelten:

| Ausgeschlossen sind                                                                 | Abweichung                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen                          | keine                                                                                                                                                                                                                 |
| Rein kosmetische Leistungen wie Bleaching oder Veneers ohne medizinische Indikation | keine                                                                                                                                                                                                                 |
| Behandlungen durch nicht approbierte Behandler                                      | keine                                                                                                                                                                                                                 |
| Bei Vertragsschluss fehlende Zähne                                                  | brillant und brillant mit Selbstbehalt:<br>Aufwendungen für den Ersatz von bis zu zwei bei Vertragsschluss fehlenden Zähnen, wenn die Behandlung nach Ablauf von zwölf Monaten seit Versicherungsbeginn begonnen wird |

Dazu die Wartezeit des Tarifs, die Zahnstaffel der ersten drei Versicherungsjahre beziehungsweise vier Versicherungsjahre, ein etwaiger Selbstbehalt (100 EUR bei balance, 250 EUR bei brillant mit Selbstbehalt) und bei brillant die Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR, die nach Ablauf der Staffel greift.

Bei fehlenden Zähnen ist die Ausnahme eng, und sie wird genau so wiedergegeben — bis zu zwei Zähne, und nur bei Behandlungsbeginn nach Ablauf von zwölf Monaten seit Versicherungsbeginn. In allen anderen Tarifen ist das ausgeschlossen.

Ebenso wichtig: „Vollschutz“ heißt nicht „unbegrenzt“. Bei brillant gilt eine Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR. Diese Erwartung entsteht leicht und muss aktiv korrigiert werden.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Das kann ich nachvollziehen, und ich will gar nicht dagegenreden. Ich mache es deshalb anders herum und sage Ihnen zuerst, wofür nicht geleistet wird: für alles, was Ihr Zahnarzt bereits angeraten hat, für Zähne, die heute schon fehlen, und für rein kosmetische Sachen. Dazu kommen drei Monate Wartezeit und in den ersten Jahren eine Höchstsumme. Wenn Ihnen dann noch etwas unklar ist, gehen wir das durch.“

**Passt** fast immer.

**Passt nicht** wenn sie als Rhetorik gemeint ist und danach doch die Einschränkungen kleingeredet werden — dann richtet sie mehr Schaden an als jede Ausweichantwort.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn das Misstrauen so grundsätzlich ist, dass keine Auskunft es auflöst, hat weiteres Reden keinen Sinn. Dann wird angeboten, die Bedingungen zur Verfügung zu stellen, und das Gespräch endet. Auch das ist ein ordentliches Ergebnis.

## 45. Einwand „Schicken Sie mir erst mal Unterlagen“

### Was dahintersteckt

Drei Möglichkeiten: ein echter Wunsch, in Ruhe nachzulesen; ein Zeitproblem im Moment des Gesprächs; oder eine höfliche Ablehnung. Für die Behandlung des Einwands ist der Unterschied unerheblich — die zulässige Reaktion ist in allen drei Fällen dieselbe.

### Sachliche Antwort

Unterlagen werden geschickt. Punkt. Der Wunsch wird nicht als Vorwand behandelt und nicht kommentiert. Ausdrücklich unzulässig ist die verbreitete Erwiderung „Was müsste denn drin-

stehen, damit Sie sich entscheiden?“ in ihren Varianten — sie ist eine Technik, den Wunsch zu umgehen, und sie fällt unter das Verbot des Drängens. Ebenso unzulässig: das Angebot davon abhängig zu machen, dass „wir dann gleich einen Termin ausmachen“, oder anzudeuten, die Unterlagen allein reichten zur Entscheidung nicht aus.

Zulässig ist genau eine sachliche Rückfrage, und sie dient dazu, die richtigen Unterlagen zu schicken: „Damit ich Ihnen das Passende schicke — soll ich alle vier Tarife beilegen oder den, über den wir gesprochen haben?“ Zulässig ist außerdem, kurz zu benennen, worauf zu achten ist: die Wartezeit, die Zahnstaffel, ein etwaiger Selbstbehalt und die Ausschlüsse. Das ist keine Verkaufstechnik, sondern eine Lesehilfe.

Ein Rückruf darf angeboten, aber nicht gesetzt werden. „Ich melde mich Donnerstag“ ist keine Vereinbarung, sondern eine Ankündigung — und damit Druck. Richtig ist: „Wenn es Ihnen recht ist, melde ich mich in etwa zwei Wochen. Sagen Sie mir gern, wenn Ihnen das zu früh oder zu spät ist, oder wenn Sie sich lieber selbst melden.“

#### **MUSTERFORMULIERUNG**

„Mache ich gern. Ich lege Ihnen die Bedingungen bei und markiere zwei Stellen, die erfahrungsgemäß die wichtigsten sind: die Wartezeit und die Aufzählung, wofür nicht geleistet wird. Wenn Sie dazu Fragen haben, erreichen Sie mich unter der Nummer, die auf dem Anschreiben steht.“

**Passt** immer.

**Passt nicht** mit dem Zusatz „und ich rufe Sie dann an“, wenn die Kundin oder der Kunde dem nicht zugestimmt hat.

### **Wann der Einwand berechtigt ist**

Wer etwas Schriftliches lesen will, bevor er einen Vertrag über Jahre abschließt, hat recht. Der Einwand ist immer berechtigt. Dass ein Teil dieser Gespräche nie fortgesetzt wird, ist eingepreist und ändert nichts an der Regel.

## **46. Einwand „Ich bin zu alt dafür“**

### **Was dahintersteckt**

Entweder die Sorge, gar nicht mehr aufgenommen zu werden, oder die Rechnung „so lange zahle ich, bis es sich lohnt“, oder die Annahme, ein bereits reparierter Zahn mache den Vertrag sinnlos. Alle drei Annahmen lassen sich sachlich prüfen.

### **Rückfrage, die das klärt**

„Darf ich fragen, wie alt Sie sind?“ Danach ist die Auskunft eindeutig, denn die Altersgrenzen sind harte Kriterien und keine Ermessensfrage. Zusätzlich: „Fehlt Ihnen aktuell ein Zahn, oder ist etwas in Behandlung?“ — das entscheidet oft mehr als das Alter.

### **Sachliche Antwort**

Die Eintrittsaltersgrenzen im Produktmodell stehen in Abschnitt 26. Ab 66 Jahren ist brillant in beiden Varianten nicht mehr abschließbar; dann ist balance der umfassendste noch mögliche Tarif — mit allen Leistungsbereichen, 100 EUR Selbstbehalt im Jahr und drei Monaten Wartezeit. Ab 71 Jahren ist kein Tarif mehr abschließbar. Das wird klar gesagt und nicht umschrieben.

Zur Rechnung „bis es sich lohnt“: Die Zahnstaffel läuft bei balance über vier Versicherungsjahre, bei brillant über drei Versicherungsjahre. Danach greift sie nicht mehr. Bei unfallbedingten



Behandlungen entfällt sie von Anfang an. Ob sich das für die eigene Lebensplanung rechnet, entscheidet die Kundin oder der Kunde — der Vertrieb stellt die Zahlen bereit und rechnet keine Lebenserwartung vor.

Zur Annahme, es sei ohnehin zu spät: Bereits fehlende Zähne sind ausgeschlossen, mit der engen Ausnahme in brillant und brillant mit Selbstbehalt für bis zu zwei bei Vertragsschluss fehlende Zähne, deren Ersatz nach Ablauf von zwölf Monaten begonnen wird. Alles, was künftig entsteht, ist normal versichert. Ein reparierter Zahn macht den Vertrag also nicht sinnlos — ein fehlender schränkt ihn ein.

#### **MUSTERFORMULIERUNG**

„Bei uns geht smart und balance bis einschließlich 70 Jahre, brillant bis 65. Mit Ihren Angaben wäre balance der Tarif, über den wir sprechen würden.“

Was ich Ihnen offen sagen muss: Zähne, die heute schon fehlen, sind dort nicht mitversichert.“

**Passt** solange die Altersgrenze eingehalten ist.

**Passt nicht** oberhalb der Grenze — dort gibt es nichts zu formulieren, sondern nur mitzuteilen.

### **Wann der Einwand berechtigt ist**

Ab 71 Jahren ist der Einwand schlicht zutreffend: Es gibt kein Angebot. Das wird ohne Umweg gesagt. Auch unterhalb der Grenze kann er zutreffen, etwa wenn mehrere Zähne fehlen und der Bedarf genau dort liegt — dann bleibt vom Nutzen wenig übrig, und das gehört gesagt statt verschwiegen.

## **47. Einwand „Ich habe schon eine Zahnzusatzversicherung“**

### **Was dahintersteckt**

Entweder ein bestehender, passender Vertrag — dann ist das Gespräch fachlich schnell zu Ende. Oder ein bestehender Vertrag, dessen Umfang die Kundin oder der Kunde nicht kennt. Oder ein Vertrag, mit dem es bereits Ärger gab.

### **Rückfrage, die das klärt**

„Wissen Sie, was dort versichert ist — sind zum Beispiel Implantate und Parodontose dabei?“ Und: „Besteht der Schutz durchgehend, ohne Unterbrechung?“ Die zweite Frage ist im Produktmodell folgenreich.

### **Sachliche Antwort**

Bei brillant und brillant mit Selbstbehalt entfällt die Wartezeit von drei Monaten vollständig, wenn ein lückenloser Vorversicherungsschutz besteht. Das ist der einzige Vorteil, der aus einer Vorversicherung folgt — und er ist präzise zu benennen, weil daraus regelmäßig mehr abgeleitet wird, als er hergibt. Was ausdrücklich nicht entfällt: Die Zahnstaffel beginnt mit dem neuen Vertrag neu. Der Ausschluss angeratener oder begonnener Behandlungen gilt unverändert. Bei Vertragsschluss fehlende Zähne bleiben ausgeschlossen, abgesehen von der Ausnahme für bis zu zwei Zähne bei brillant und brillant mit Selbstbehalt nach zwölf Monaten. Und es findet eine erneute Gesundheitsprüfung statt.

Genau darin liegt auch der Grund, warum ein Wechsel oder ein späteres Aufstocken kein harmloser Schritt ist: Wer klein einsteigt und später mehr will, trifft auf eine erneute Gesundheitsprüfung, eine erneute Wartezeit und eine erneut beginnende Zahnstaffel. Diese Information gehört in jedes Wechselgespräch, auch wenn sie gegen den Wechsel spricht.

Ein Vergleich mit dem bestehenden Vertrag wird nur anhand von Leistungsmerkmalen geführt, nicht über den Anbieter. Sinnvolle Prüfpunkte sind: Sind Implantate versichert und mit welcher Fallzahl (balance höchstens vier Behandlungen in fünf Versicherungsjahren, brillant höchstens acht Behandlungen in fünf Versicherungsjahren)? Ist Parodontose versichert (in smart nicht)? Gibt es einen Selbstbehalt? Gibt es eine Jahreshöchstgrenze (bei brillant 5.000 EUR)?

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Dann ist die Frage nicht, ob Sie etwas brauchen, sondern ob das, was Sie haben, zu dem passt, was Sie erwarten. Wenn Sie mir sagen, was dort versichert ist, sage ich Ihnen offen, wo wir besser sind und wo nicht. Und einen Punkt möchte ich vorwegschicken: Ein neuer Vertrag heißt auch neue Gesundheitsprüfung und eine neue Zahnstaffel — die Wartezeit entfiel bei brillant, die Staffel lief aber von vorn.“

**Passt** wenn der bestehende Vertrag erkennbar Lücken hat.

**Passt nicht** wenn der bestehende Schutz mindestens gleichwertig ist — dann wird kein Vergleich gesucht, sondern das Ergebnis genannt.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn der bestehende Vertrag den Bedarf gleich gut oder besser deckt, ist der Einwand berechtigt und wird bestätigt: „Dann würde ich an Ihrer Stelle nichts ändern.“ Ein Wechsel, der eine neue Staffel und eine neue Gesundheitsprüfung auslöst, ohne einen erkennbaren Vorteil zu bringen, ist eine Verschlechterung — auch wenn er ein Abschluss wäre.

## 48. Einwand „Warum ist der Selbstbehalt überhaupt drin?“

### Was dahintersteckt

Meistens der Verdacht, es handle sich um eine versteckte Einschränkung. Manchmal auch ein echtes Missverständnis über die Wirkungsweise — die Annahme nämlich, der Selbstbehalt falle je Leistungsbereich oder gar je Rechnung an.

### Rückfrage, die das klärt

„Wie haben Sie den Selbstbehalt bisher verstanden — pro Rechnung oder pro Jahr?“ Diese Frage deckt das häufigste Missverständnis auf, bevor es zum Leistungsfall wird.

### Sachliche Antwort

Im Produktmodell gibt es zwei Tarife mit Selbstbehalt.

| Tarif                               | Selbstbehalt je Versicherungsjahr |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| atra.dent.brillant                  | keiner                            |
| atra.dent.brillant mit Selbstbehalt | 250 EUR                           |
| atra.dent.balance                   | 100 EUR                           |
| atra.dent.smart                     | keiner                            |

Bei balance gilt er einmal im Jahr über alle Leistungsbereiche zusammen, nicht je Bereich und nicht je Rechnung. Das ist erfahrungsgemäß der am häufigsten missverstandene Punkt im gesamten Produkt und deshalb aktiv zu erklären. Bei brillant mit Selbstbehalt ist der Leistungsumfang im Übrigen mit brillant identisch: dieselben Quoten, dieselbe Zahnstaffel über

drei Versicherungsjahre, dieselbe Jahreshöchstgrenze von 5.000 EUR. Diese Variante ist kein kleinerer Schutz, sondern derselbe Schutz mit Eigenbeteiligung.

Der Selbstbehalt ist kein Trick, sondern eine Tauschentscheidung: niedrigerer Beitrag gegen Eigenbeteiligung im Leistungsfall. Ob sich das lohnt, hängt am Nutzungsmuster. Wer selten, dann aber große Rechnungen erwartet, fährt mit Selbstbehalt gut. Wer regelmäßig kleinere Behandlungen hat, zahlt den Selbstbehalt jedes Jahr aufs Neue — dann ist ein Tarif ohne Selbstbehalt in aller Regel die bessere Wahl, und das ist zu sagen, auch wenn die Variante mit Selbstbehalt günstiger aussieht.

#### MUSTERFORMULIERUNG

„Der Selbstbehalt ist die Stellschraube für den Beitrag, sonst nichts. Bei balance sind es 100 EUR im Jahr — einmal im Jahr, über alle Behandlungen zusammen, nicht pro Rechnung und nicht pro Bereich. Wenn Sie ohnehin jedes Jahr beim Zahnarzt etwas machen lassen, greift das jedes Jahr; dann würde ich Ihnen eher einen Tarif ohne Selbstbehalt anschauen.“

**Passt** wenn der Selbstbehalt zur Debatte steht.

**Passt nicht** wenn er bagatellisiert wird („das merken Sie gar nicht“) — das ist genau die Aussage, an der später die Enttäuschung hängt.

### Wann der Einwand berechtigt ist

Wenn ein Selbstbehalt grundsätzlich abgelehnt wird und Vollschutz bezahlbar ist, ist brillant der richtige Tarif und balance scheidet aus. Wenn regelmäßige kleinere Behandlungen absehbar sind, ist der Einwand fachlich richtig, und die Empfehlung wird geändert — nicht verteidigt.

## 49. Einwand „Was ist, wenn ich kündige — war das dann umsonst?“

### Was dahintersteckt

Die Vorstellung, es werde etwas angespart, das bei Kündigung verfällt. Dahinter steht oft die Erfahrung mit Lebens- oder Rentenversicherungen und die Übertragung dieser Logik auf eine Krankenzusatzversicherung.

### Rückfrage, die das klärt

„Denken Sie an eine bestimmte Situation — etwa einen Jobwechsel oder einen Umzug ins Ausland?“ Häufig steckt eine konkrete Unsicherheit dahinter, die sich sachlich beantworten lässt, ohne über Kündigung im Allgemeinen zu reden.

### Sachliche Antwort

Eine Zahnzusatzversicherung ist eine Risikoversicherung, kein Sparvertrag. Es wird kein Guthaben aufgebaut, das ausgezahlt oder verrechnet werden könnte. Beahlt wird der Schutz für den jeweiligen Zeitraum — er war vorhanden, ob er in Anspruch genommen wurde oder nicht. Das ist unbequem, aber es ist die ehrliche Antwort, und sie ist besser als jede Umschreibung.

Zu Laufzeit, Kündigungsfristen und Kündigungsterminen enthält dieses Handbuch bewusst keine Angaben. Maßgeblich sind die Bedingungen und der Versicherungsschein; danach wird dort nachgesehen und daraus wird zitiert, statt aus dem Gedächtnis zu antworten.

Was aber gesagt werden kann und im Produktmodell steht: Ein späterer Neuabschluss beginnt bei null. Es findet eine erneute Gesundheitsprüfung statt, es läuft eine erneute Wartezeit, und die Zahnstaffel beginnt neu — die Stufen stehen in Abschnitt 40. Wer also mit dem Gedanken spielt, den Vertrag „erst mal zu probieren“ und bei Bedarf später wieder abzuschließen, sollte wissen,

dass die durchlaufenen Staffeljahre dabei verloren gehen. Ein Restnutzen bleibt allerdings: Bei brillant und brillant mit Selbstbehalt entfällt die Wartezeit, wenn lückenloser Vorversicherungsschutz besteht — ein durchgehend gehaltener Vorvertrag hat also für einen späteren Wechsel einen konkreten Wert.

#### **MUSTERFORMULIERUNG**

„Nein, angespart wird nichts — Sie zahlen für den Schutz in der Zeit, in der er besteht. Wenn Sie kündigen, ist er zu Ende, und ein neuer Vertrag später fängt bei der Wartezeit und der Staffel wieder von vorn an. Zu den Fristen schaue ich Ihnen gern in den Bedingungen die genaue Stelle heraus, damit Sie das schriftlich haben.“

**Passt** als Antwort auf die Frage nach dem Sinn.

**Passt nicht** mit einer aus dem Kopf genannten Kündigungsfrist — dazu wird nachgesehen.

### **Wann der Einwand berechtigt ist**

Wenn erkennbar ist, dass die Absicherung nur kurzfristig gedacht ist, etwa für eine einzelne geplante Behandlung, trägt der Einwand vollständig. Für eine kurzfristige Nutzung ist das Produkt wegen Wartezeit, Zahnstaffel und Ausschluss angeratener Behandlungen ungeeignet, und das ist zu sagen.

## **50. Einwand nach der Diagnose: „Mein Zahnarzt hat mir gerade eine Krone empfohlen“**

Dies ist der heikelste Einwand in diesem Kapitel, und er ist der einzige, bei dem die Antwort feststeht, bevor das Gespräch beginnt.

### **Was dahintersteckt**

Ein konkreter, oft erschreckender Kostenvoranschlag und die Hoffnung, ihn noch abfangen zu können. Der Anruf kommt häufig unmittelbar nach dem Zahnarzttermin. Die Erwartungshaltung ist hoch, und die Enttäuschung wird es auch sein.

### **Die Antwort**

Vor Vertragsschluss angeratene oder begonnene Behandlungen sind in allen vier Tarifen ausgeschlossen. Für die empfohlene Krone wird nicht geleistet — nicht bei smart, nicht bei balance, nicht bei brillant, nicht bei brillant mit Selbstbehalt. Das gilt unabhängig davon, ob bereits ein Heil- und Kostenplan vorliegt, wann der Behandlungstermin ist und wie lange die Wartezeit des Tarifs wäre. Es gibt hier keine Auslegungsfrage, keinen Ermessensspielraum und keine Kulanzhoffnung, die man in Aussicht stellen dürfte.

Das wird klar, früh und unmissverständlich gesagt. Wer hier ausweicht („das prüft dann die Leistungsabteilung“, „das kommt darauf an“), erzeugt eine Erwartung, die spätestens mit dem ersten Ablehnungsschreiben zusammenbricht — mit einer Beschwerde, einer Stornierung und einem berechtigten Vorwurf als Folge.

**KEIN AUSWEG WIRD ANGEDEUTET**

Ausdrücklich unzulässig ist jede Andeutung in Richtung eines Auswegs: den Vertrag vor dem nächsten Zahnarzttermin abzuschließen, den Heil- und Kostenplan zurückzuhalten, die Antragsfragen zum Gesundheitszustand unvollständig zu beantworten oder den Behandlungsbeginn zu verschieben, um die Reihenfolge zu verändern. Antragsfragen werden vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet; alles andere gefährdet den gesamten Schutz und ist keine Beratung, sondern eine Anstiftung.

**Rückfrage, die klärt, was noch bleibt**

„Ist außer der Krone noch etwas geplant oder besprochen worden?“ Und, weil das im Produktmodell Folgen hat: „Fehlt Ihnen aktuell ein Zahn?“ Bei Vertragsschluss fehlende Zähne sind ebenfalls ausgeschlossen; nur brillant und brillant mit Selbstbehalt sehen eine Ausnahme für bis zu zwei fehlende Zähne vor, wenn die Behandlung nach Ablauf von zwölf Monaten seit Versicherungsbeginn beginnt.

**Was trotzdem sinnvoll bleibt**

Der Ausschluss betrifft die angeratene Behandlung, nicht die Zukunft. Ein Gebiss, an dem eine Krone nötig wird, ist selten das letzte Ereignis. Alles, was künftig neu entsteht und noch nicht angeraten ist, wäre normal versichert — mit den Wartezeiten und der Zahnstaffel. Ein Abschluss kann deshalb weiterhin sinnvoll sein; er löst nur das akute Problem nicht. Diese Unterscheidung ist der Kern des Gesprächs, und sie muss so deutlich sein, dass sie in keiner Richtung missverstanden werden kann.

**MUSTERFORMULIERUNG**

„Da muss ich Ihnen leider eine klare Absage geben: Was Ihr Zahnarzt bereits angeraten hat, ist in allen unseren Tarifen ausgeschlossen — für diese Krone würden wir nicht leisten, egal welchen Tarif Sie wählen und egal wann die Behandlung stattfindet. Ich sage Ihnen das lieber jetzt als in einem halben Jahr im Ablehnungsschreiben. Was ein Vertrag ab heute leisten würde, ist alles, was künftig neu dazukommt und noch nicht besprochen ist. Ob Ihnen das den Beitrag wert ist, ist Ihre Entscheidung — für die Krone hilft es nicht.“

**Passt** sobald eine Behandlung angeraten wurde.

**Passt nicht** in einer abgeschwächten Variante; jede Relativierung an dieser Stelle ist ein Fehler.

**Wann der Einwand berechtigt ist und das Gespräch endet**

Wenn die Kundin oder der Kunde ausschließlich wegen dieser Behandlung anruft, ist der Einwand berechtigt und das Gespräch endet ohne Abschluss. Es wird dann kein Ersatzangebot nachgeschoben und kein zweiter Anlauf unternommen. Was bleibt, ist ein Angebot ohne Bedingung: sich zu melden, wenn die Behandlung abgeschlossen ist und die Frage nach künftigem Schutz wieder offen ist. Sinnvollerweise mit dem Hinweis, dass der günstigste Zeitpunkt für einen Abschluss immer der ist, an dem noch nichts angeraten wurde — genau deshalb steht dieser Satz auch am Anfang jedes anderen Gesprächs.

**51. Wenn der Einwand trägt: das Gespräch ohne Abschluss beenden**

Ein Gespräch, das ohne Abschluss endet, ist ein reguläres Ergebnis und wird auch so behandelt. Es gibt vier Situationen, in denen das sachlich richtig ist:

- a) Es besteht kein Bedarf.
- b) Der Bedarf lässt sich mit keinem der vier Tarife decken, etwa weil die Behandlung bereits angeraten ist oder das Eintrittsalter über 70 liegt.
- c) Der Beitrag übersteigt auch beim passenden Tarif das Budget.
- d) Die Kundin oder der Kunde will nicht — aus welchem Grund auch immer, und ohne dass dieser Grund erfragt werden müsste.

In allen vier Fällen gilt dasselbe Vorgehen: das Ergebnis benennen, den Grund kurz nennen, nichts nachschieben. Kein weiteres Angebot, keine Rückfrage nach dem „eigentlichen“ Grund, keine Ankündigung eines Rückrufs ohne Zustimmung. Wer nach einem klaren Nein noch einmal ansetzt, verstößt gegen die Grenze des Nichtdrängens — unabhängig davon, wie freundlich der zweite Anlauf formuliert ist.

Was zulässig bleibt: die Bedingungen zur Verfügung zu stellen, wenn das gewünscht ist, und anzubieten, dass die Kundin oder der Kunde sich melden kann. Das Angebot geht in diese Richtung, nicht umgekehrt.

Eine Notiz zum Gesprächsergebnis gehört in die Dokumentation, damit ein späteres Gespräch nicht bei null beginnt — und damit niemand in vier Wochen dieselbe Empfehlung noch einmal vorträgt. Wie dokumentiert und wie ein Folgekontakt aufgebaut wird, steht in Abschnitt 17.